ELEVIFY

BONO

HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

Cuándo estirar no es la respuesta: el alumno hiperlaxo, las lesiones del que estira mal y cómo volver



28 PÁGINAS · HIPERLAXITUD · DESGARROS
PUBALGIA · TENDINOPATÍAS · RETORNO

CONTROL · FUERZA EN RANGO · CÁPSULA · DERIVAR

HIPERMOVILIDAD Y LESIONES:
CUÁNDO ESTIRAR NO ES LA RESPUESTA

HIPERMOVILIDAD Y LESIONES



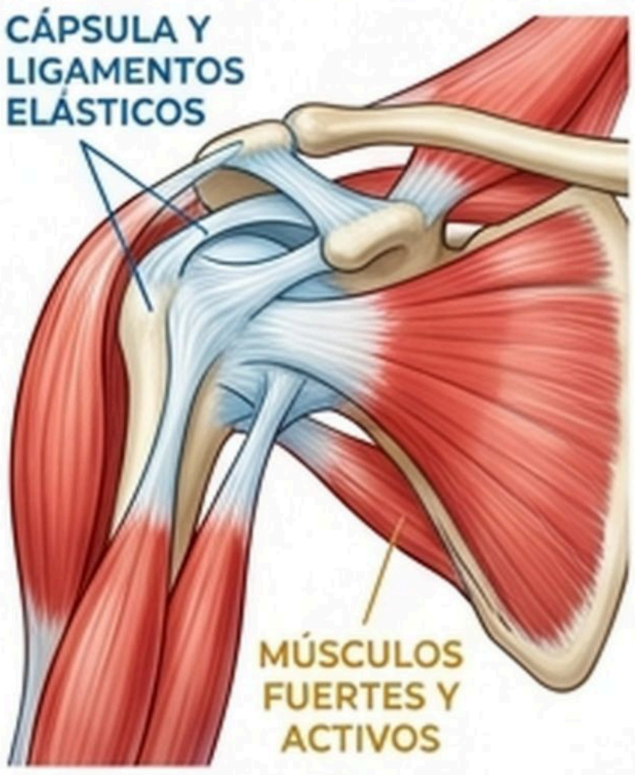
QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo bono vas a entender la diferencia entre flexibilidad y laxitud, a reconocer al alumno hiperlaxo en tu sala y a darle las herramientas que de verdad necesita: control y fuerza en los rangos que ya tiene, para que el movimiento sea seguro y eficiente.

LAXITUD, HIPERMOVILIDAD, INESTABILIDAD

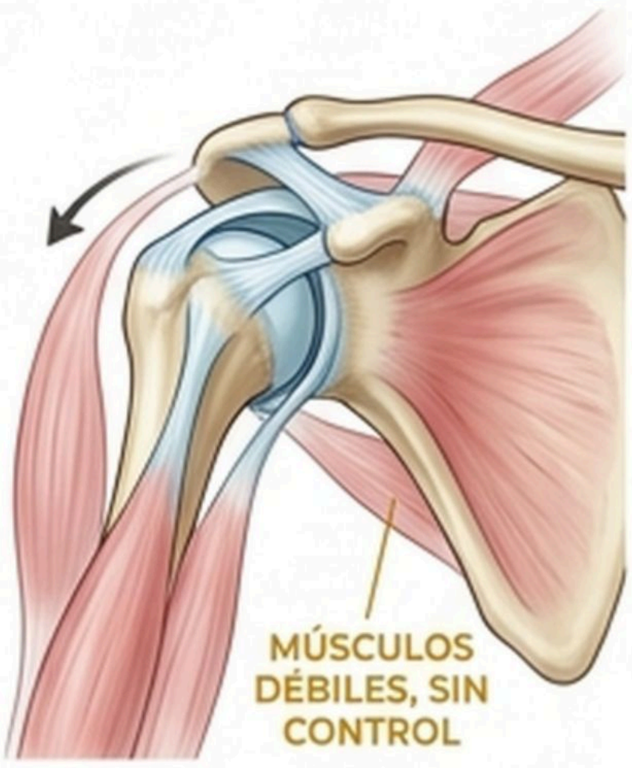
LAXITUD

LAXITUD



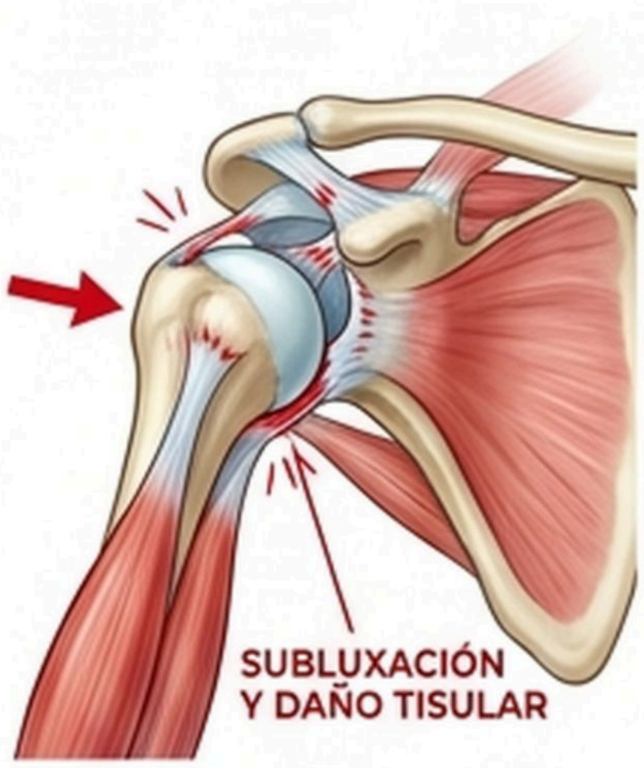
Característica del tejido: ligamentos más elásticos. Neutra.

HIPERMOVILIDAD



Capacidad de mover más allá del rango normal, pero sin control muscular.

INESTABILIDAD



Resultado final no deseado: la articulación se luxa o subluxa. Genera dolor.

QUÉ ES CADA COSA Y POR QUÉ IMPORTA

LAXITUD (NEUTRA): La laxitud es una característica del tejido conectivo; tus ligamentos son inherentemente más elásticos y permiten mayor juego articular. Es una condición neutra, ni buena ni mala por sí misma, presente en muchas personas.

HIPERMOVILIDAD (CAPACIDAD): La hipermovilidad es la capacidad funcional de mover esa articulación más allá del rango considerado normal, pero sin el control muscular activo necesario para estabilizarla en los extremos. Ahí empiezan los problemas, porque el cuerpo busca estabilidad contrayendo músculos que no deberían hacer ese trabajo.

INESTABILIDAD (PATOLOGÍA): La inestabilidad es el resultado final no deseado: la articulación se luxa o subluxa de manera recurrente porque nada (ni ligamentos ni músculos) la frena dentro de su rango seguro, generando dolor, inflamación y lesiones crónicas. Entender esto te permite dejar de pedirle más rango a quien no lo necesita.

EN LA SALA

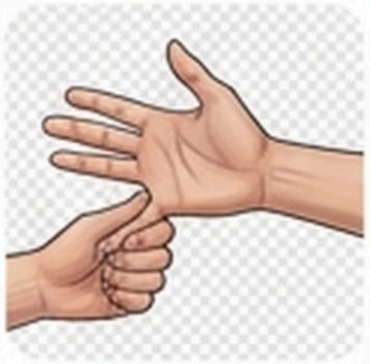


La alumna que se abre de piernas sin esfuerzo aparente, pero después de la clase le duele la cintura o el pubis. Su hipermovilidad le permite el rango, pero su falta de control y estabilidad central traslada la tensión a estructuras vulnerables.

Ejemplo práctico: flexibilidad sin estabilidad = riesgo de lesión.

CÓMO RECONOCERLO

PUNTOS CLAVE EN LA SALA Y EL CUERPO



TEST 1:
DEDO MEÑIQUE > 90°
PUNTAJE: 1 por lado



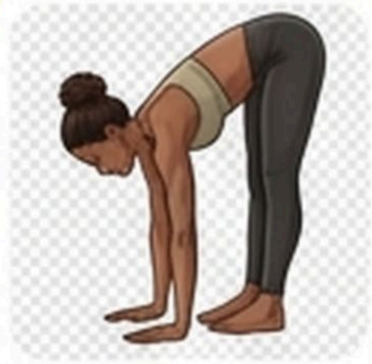
TEST 2:
PULGAR AL ANTEBRAZO
PUNTAJE: 1 por lado



TEST 3:
HIPEREXTENSIÓN DE CODO > 10°
PUNTAJE: 1 por lado



TEST 4:
HIPEREXTENSIÓN DE RODILLA > 10°
PUNTAJE: 1 por lado



TEST 5:
MANOS PLANAS AL PISO CON RODILLAS EXTENDIDAS
PUNTAJE: 1 total

ESCALA DE BEIGHTON: 9 PUNTOS TOTALES

LA HERRAMIENTA RÁPIDA EN SALA



El test de Beighton es una herramienta rápida para evaluar la hipermovilidad generalizada. Un puntaje de 5 o más sobre 9 sugiere hipermovilidad. Pero ojo, podés encontrar hipermovilidad localizada (solo en hombros, por ejemplo) sin un Beighton alto.
Observá también cómo se para: ¿las rodillas se van para atrás (genu recurvatum)? ¿Los codos se traban en hiperextensión en una plancha? A menudo, este alumno se queja de sentirse 'duro' y pide más estiramiento, una pista clave de que su sistema nervioso está creando rigidez para proteger articulaciones inestables.

EN LA SALA: OBSERVACIONES CLAVE



BIEN: ESTABILIDAD EN PLANCHA LATERAL (30+ SEG)



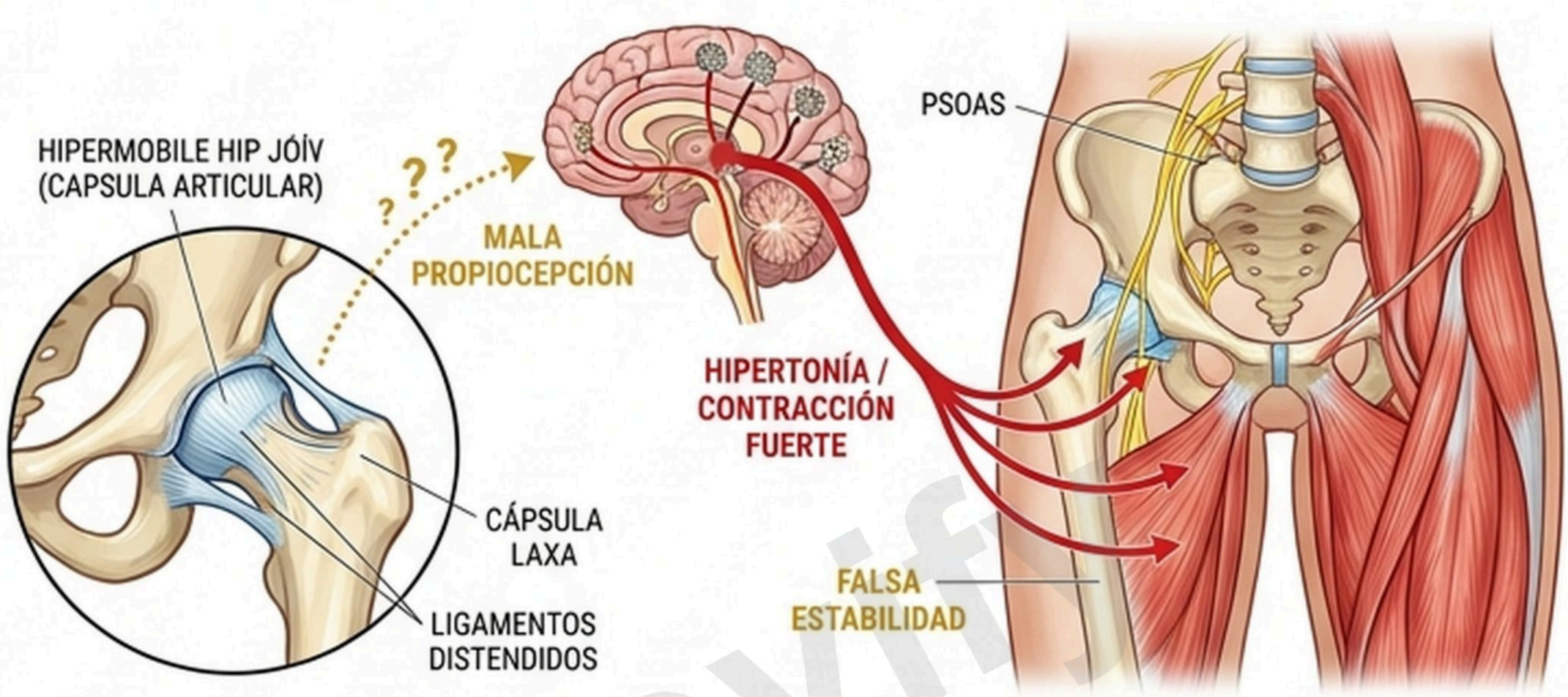
MAL: DIFICULTAD PARA SOSTENER LA PLANCHA LATERAL (MINUTOS)

El alumno que hace un puente impresionante pero no puede sostener una plancha lateral ni 30 segundos.

CAPÍTULO: POR QUÉ SE SIENTE DURO

LA RIGIDEZ FALSA

POR QUÉ SE SIENTE DURO

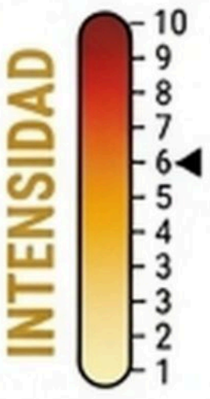


EL SISTEMA NERVIOSO COMO DEFENSA

La sensación de rigidez en una persona hiperlaxa casi nunca viene de un músculo "corto". Viene de una estrategia de protección del sistema nervioso.

Como sus ligamentos y cápsula articular son muy laxos, los sensores que informan al cerebro sobre la posición de la articulación (propioceptores) no funcionan bien. El cerebro interpreta esta falta de información como un peligro de lesión y responde contrayendo crónicamente la musculatura de alrededor.

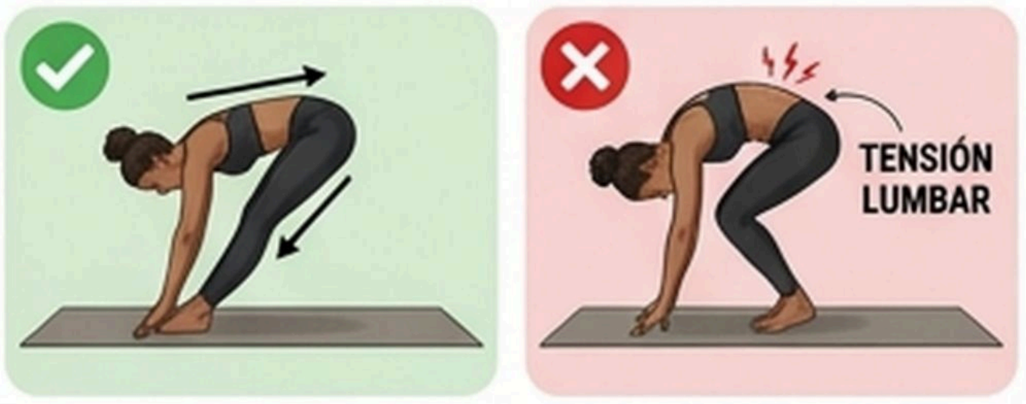
Por eso, cuando estirás pasivamente a esta persona, el sistema nervioso se resiste aún más, porque le estás quitando su única defensa.



EN LA SALA



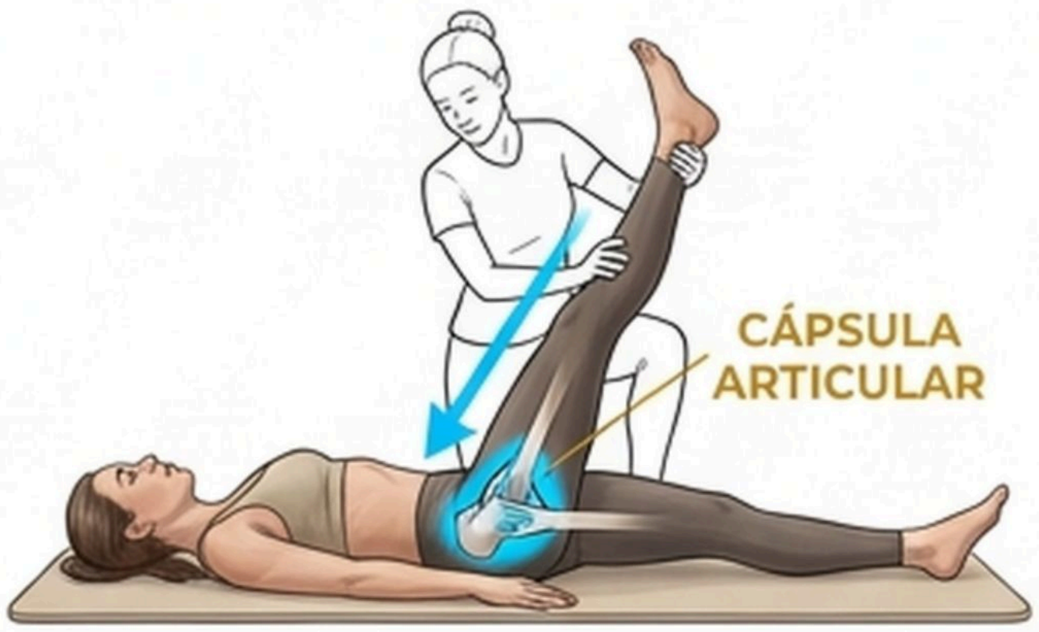
BIEN vs. MAL



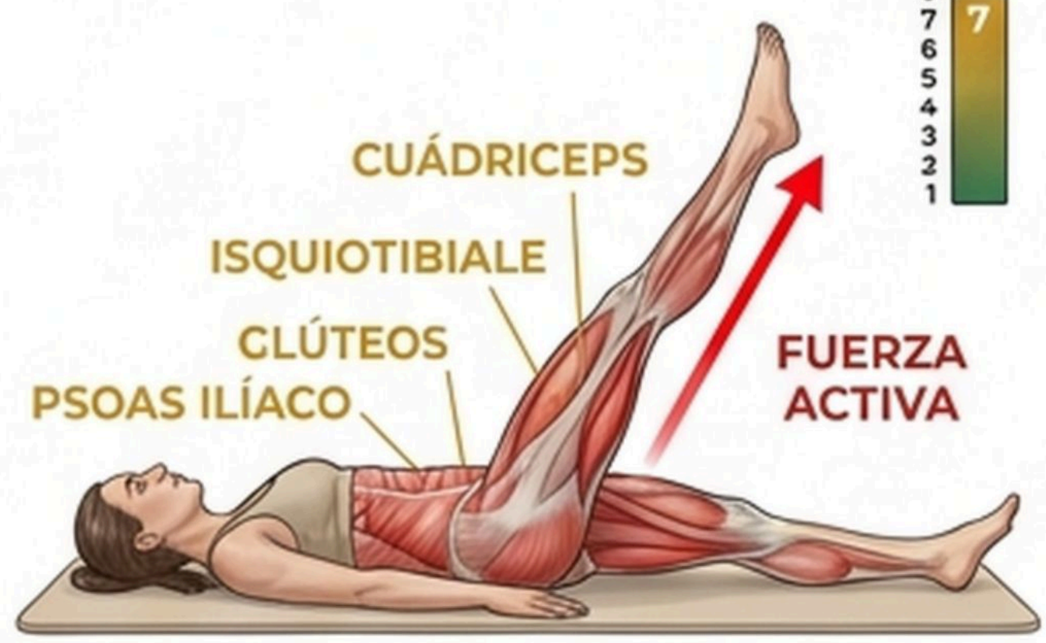
QUÉ SÍ NECESITA

FUERZA Y CONTROL

QUÉ NO



QUÉ SÍ



EL ALUMNO HIPERLAXO

El alumno hiperlaxo no necesita más rango pasivo, ya lo tiene de sobra. Lo que necesita es aprender a controlar ese rango. Su entrenamiento debe enfocarse en la fuerza, sobre todo en los rangos finales de movimiento. El objetivo es que la musculatura sea capaz de estabilizar la articulación en toda su amplitud, sin amplitud, sin depender de "colgarse" de los ligamentos o de trabar la articulación.

El trabajo excéntrico (controlar la vuelta de un movimiento) y los isométricos en rango final son sus mejores aliados. Esto le enseña a su sistema nervioso que el rango amplio puede ser un lugar seguro.

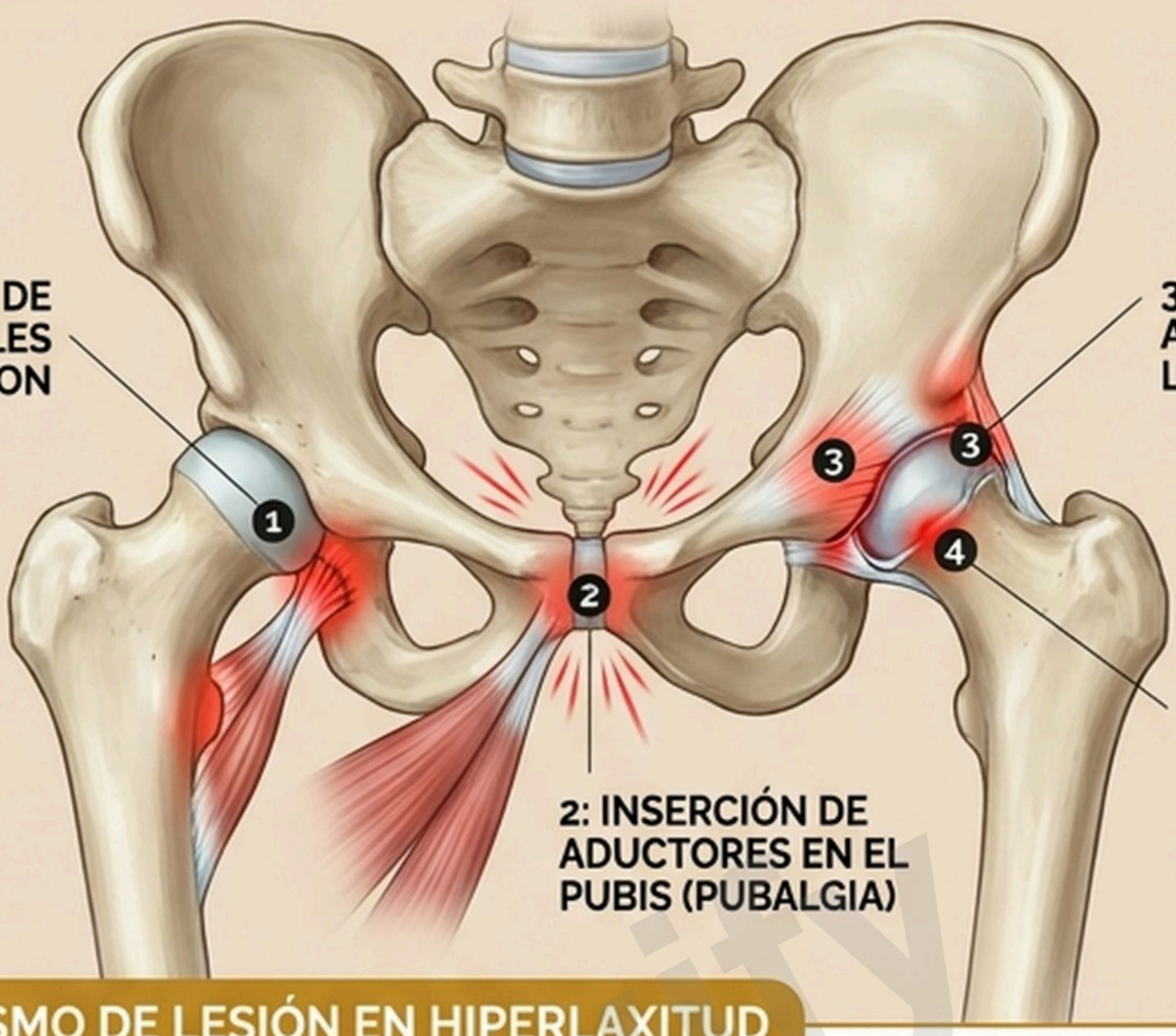
EN LA SALA



En vez de dejarla colgar en la apertura de segunda, le pedis que levante una pierna del piso apenas un centímetro y la sostenga.

QUÉ SÍ	QUÉ SÍ / QUÉ NO	QUÉ NO	QUÉ NO
• Activación de glúteos • Control del core • Ejercicios a una pierna • Trabajo de tempo lento		• Rebotes balísticos • Estiramientos pasivos sostenidos en rangos extremos • Hiperextender rodillas o codos	

LESIONES TÍPICAS



MECANISMO DE LESIÓN EN HIPERLAXITUD

Cuando un practicante hiperlaxo busca rangos extremos sin control muscular, ciertas estructuras sufren más que otras. El tendón proximal del isquiotibial se comprime contra el isquion en flexiones profundas, llevando a tendinopatías.

La sínfisis púbica se **irrita** por el **tironeo** de los aductores en **aperturas (pubalgia)**.

La cadera puede sufrir pinzamiento femoroacetabular si se fuerza la flexión o rotación más allá de lo que la forma de sus huesos permite, dañando el labrum.

Todas estas lesiones empeoran con el **estiramiento pasivo tradicional**, porque insisten en el mecanismo que las causó.

EN LA SALA



CUE DE LA FORMADORA: "No busques llegar con la frente, alargá la columna desde la cadera. Si sentis pellizco, retrocedé."

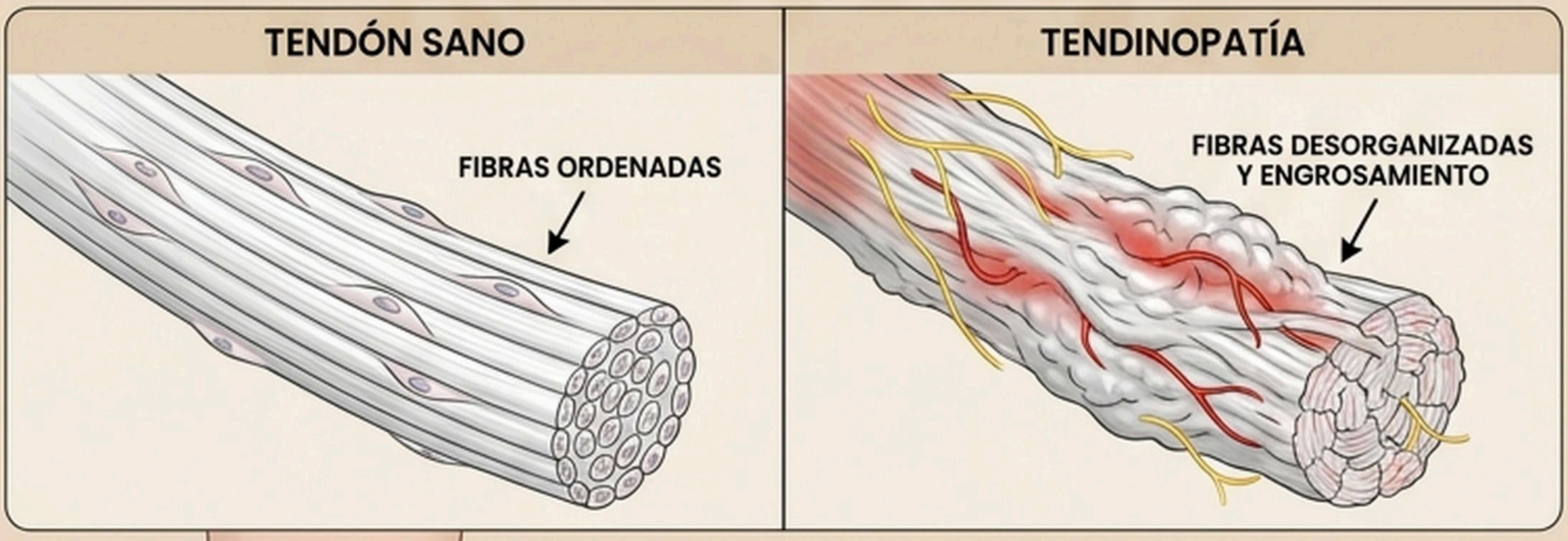


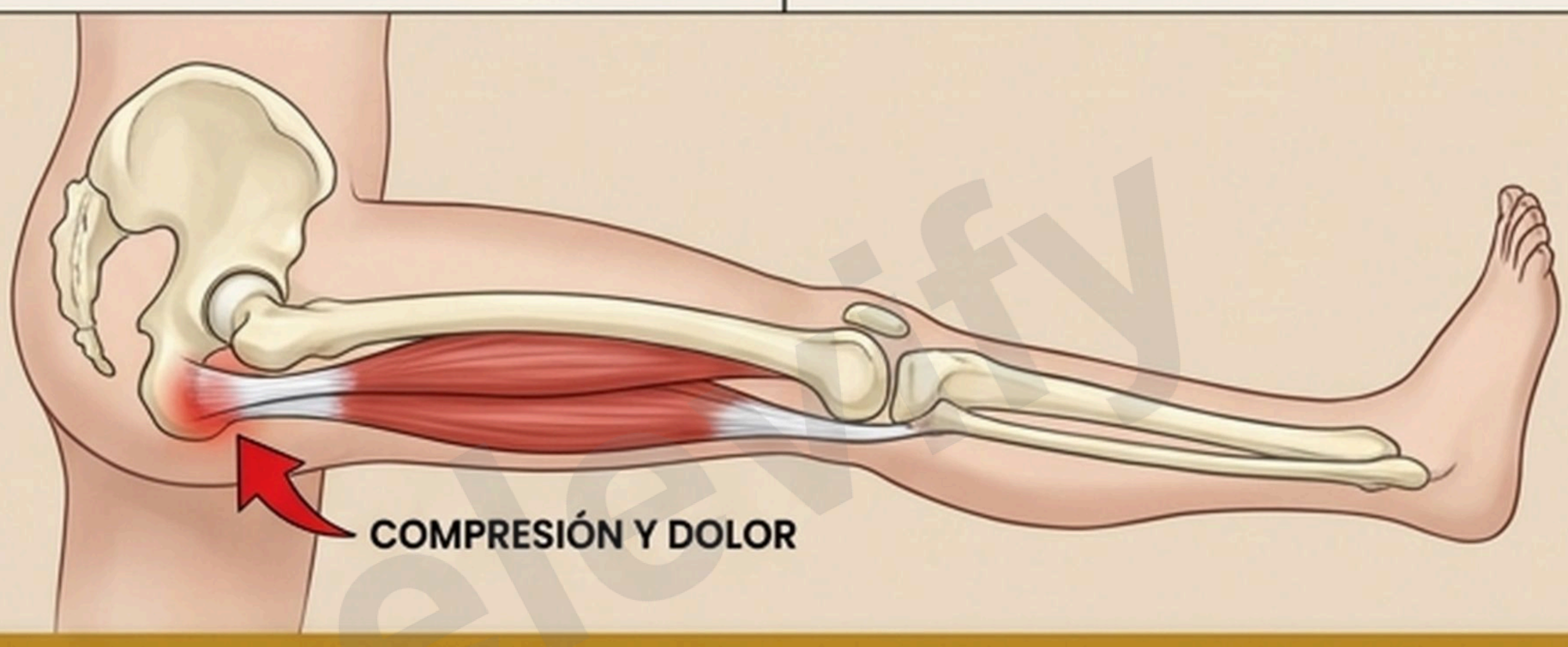
EL ALUMNO QUE SE DESGARRÓ EL ISQUIOTIBIAL "DE LA NADA" HACIENDO UNA FLEXIÓN AL FRENTE SENTADA.

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

TENDINOPATÍAS Y ESTIRAMIENTO

TENDINOPATÍAS: QUÉ PASA POR DENTRO





CARD PRINCIPAL · ¿ESTIRAR? ¡CUIDADO!

Una tendinopatía no es una inflamación (tendinitis), sino una desorganización del colágeno del tendón por sobrecarga, que puede ser por tensión o por compresión.

Estirar un tendón con tendinopatía, especialmente en la inserción proximal del isquiotibial o en el glúteo medio, a menudo lo comprime contra el hueso, lo que empeora el cuadro y aumenta el dolor.

El tendón no necesita que lo estiren, necesita carga progresiva y óptima para que sus células (tenocitos) empiecen a generar colágeno nuevo y ordenado. Por eso, el abordaje es con ejercicios de fuerza, especialmente isométricos y excéntricos.



EN LA SALA · EJEMPLO DE ERROR



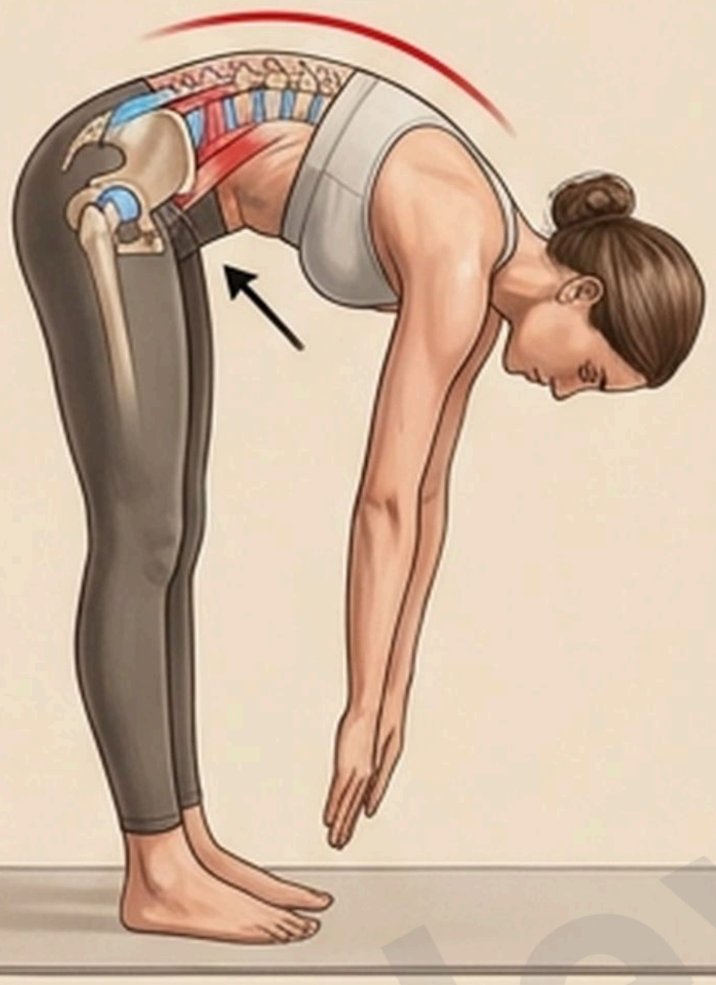
La alumna con “bursitis” de cadera que hace la postura de la paloma todos los días para que se le pase el dolor, empeorando la compresión sin saberlo.

DOLOR LUMBAR

HIPERMOVILIDAD Y COMPENSACIONES

QUÉ NO

Curva lumbar excesiva y tensión en ligamentos. Poca flexión de cadera.





QUÉ SÍ

Columna neutra y larga. Bisagra de cadera con core activado.

LA TRAMPA DE LA HIPERLAXITUD

Muchos alumnos hiperlaxos compensan la falta de control o de movilidad en la cadera con un exceso de movimiento en la columna lumbar. En vez de hacer una bisagra de cadera para flexionarse, se “quiebran” desde la cintura. Esto pone un estrés enorme en los discos intervertebrales, ligamentos y musculatura lumbar.

El dolor lumbar que aparece después de la clase de yoga o de estiramiento es una señal de alerta. El objetivo con ellos no es que lleguen más lejos, sino que aprendan a disociar el movimiento de la cadera y la columna, estabilizando el centro para que la periferia se mueva libremente.

EN LA SALA

gato contento

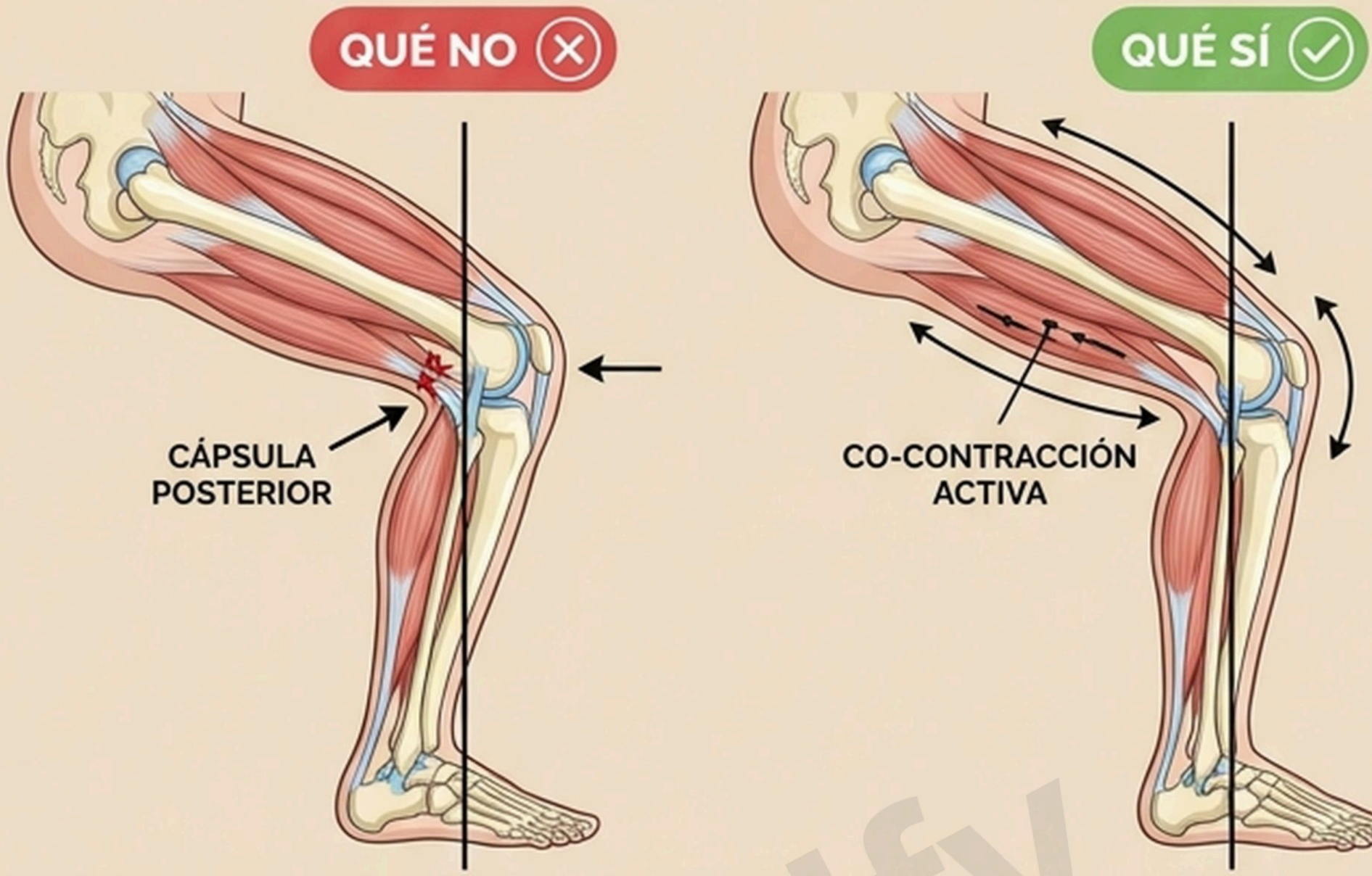


ERROR COMÚN:
Quiebre lumbar en extensión.

elevify

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

LA RODILLA HIPEREXTENDIDA



EL GENU RECURVATUM

El genu recurvatum, o hiperextensión de rodilla, es muy común en personas laxas. Al pararse o en posturas de apoyo, en vez de usar los músculos para sostenerse, 'traban' la articulación hacia atrás, colgándose de los ligamentos y la parte posterior de la cápsula. Esto no solo genera inestabilidad y posible dolor a largo plazo, sino que también inhibe la activación del cuádriceps, un músculo clave para la salud de la rodilla.

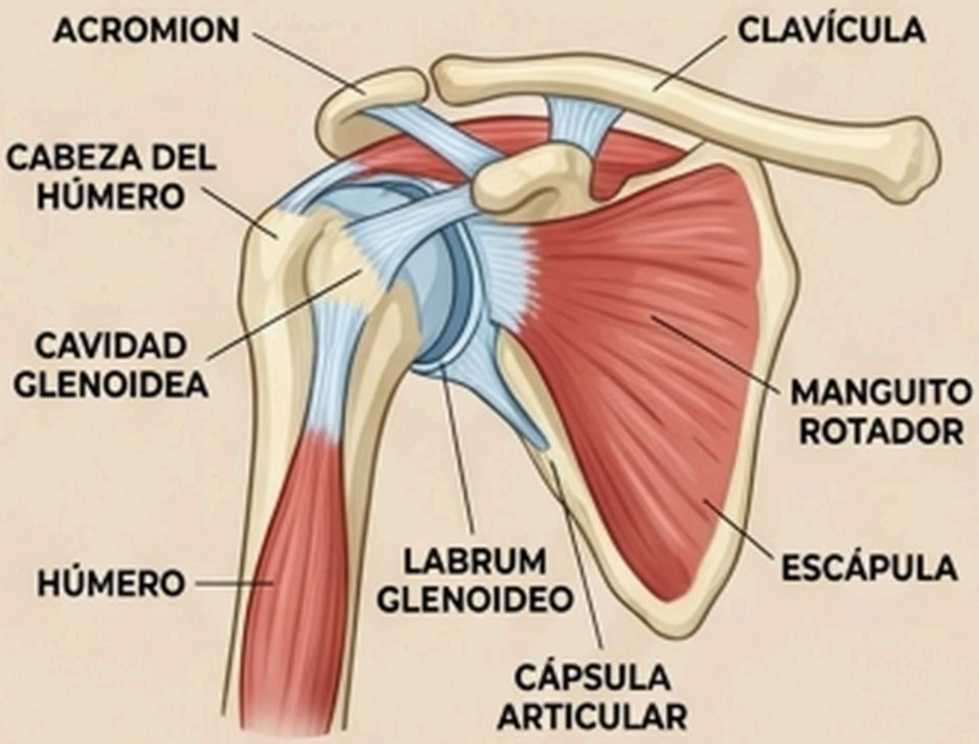
En tus clases, la clave es enseñarles a mantener una 'rodilla blanda' o en microflexión, para que la musculatura esté siempre activa y protegiendo la articulación.

EN LA SALA

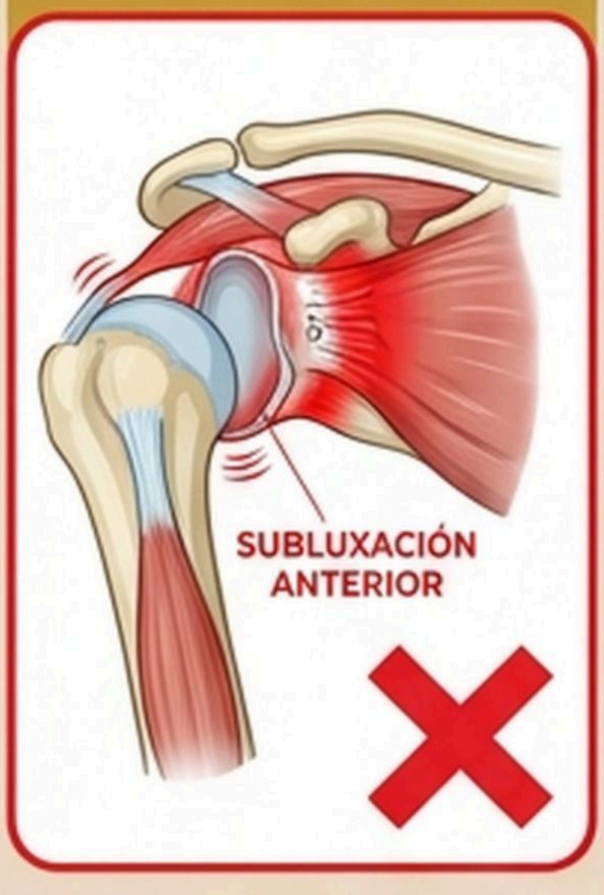
En la postura del triángulo, en vez de dejar que la rodilla de adelante se trabe hacia atrás, le pedís que la flexione un milimetro y active el muslo.



HOMBRO INESTABLE



QUÉ NO



SUBLUXACIÓN ANTERIOR: CABEZA DESPLAZADA

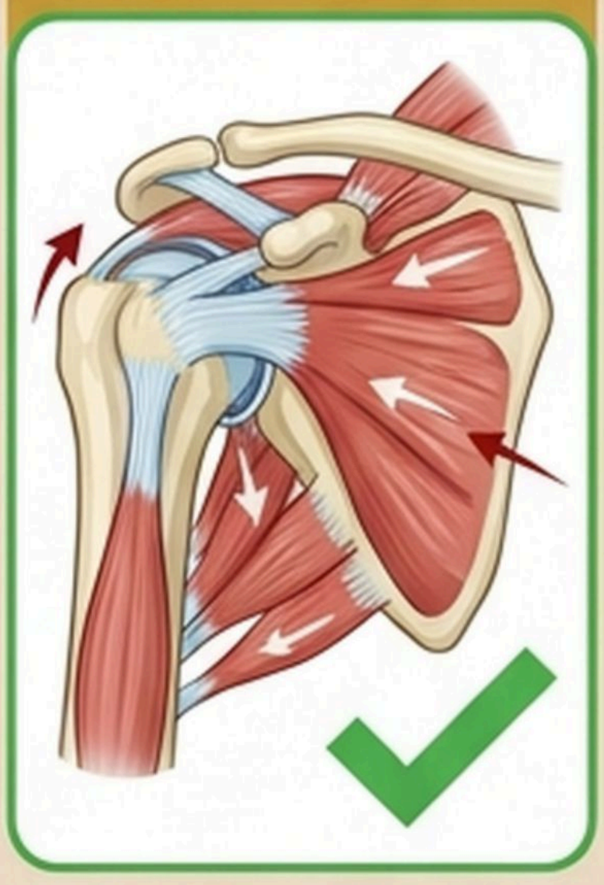
La cabeza del húmero se desplaza hacia adelante, estresando el labrum y el manguito rotador. Riesgo de lesión o inestabilidad crónica por estiramiento excesivo.

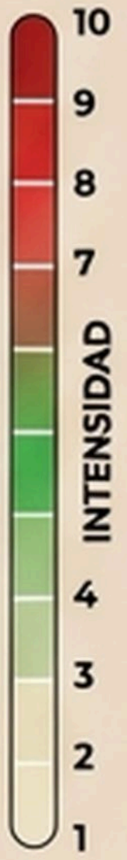
EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

El hombro es la articulación más móvil del cuerpo y, en una persona laxa, también la más inestable. Forzar la rotación externa o la extensión sin un buen control escapular y sin la activación del manguito rotador puede llevar a subluxaciones o a lesiones del labrum.

En vez de buscar más y más rango de apertura, el foco debe estar en la estabilidad. Esto implica fortalecer los músculos que 'coaptan' o centran la cabeza del húmero en su lugar, como el manguito rotador, y los que mueven y fijan la escápula, como el serrato anterior y los trapecios inferior y medio.

QUÉ SÍ





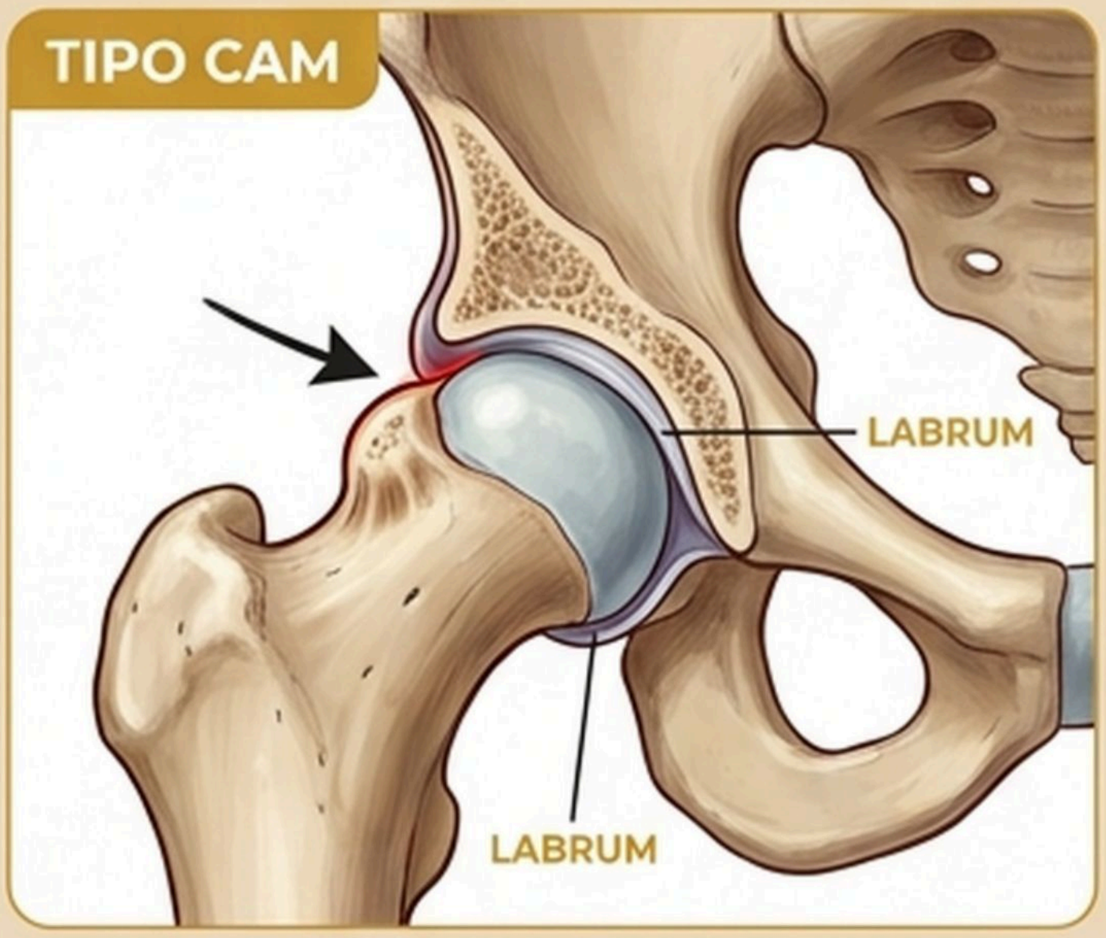
COAPTACIÓN Y CONTROL ESCAPULAR: CABEZA CENTRADA

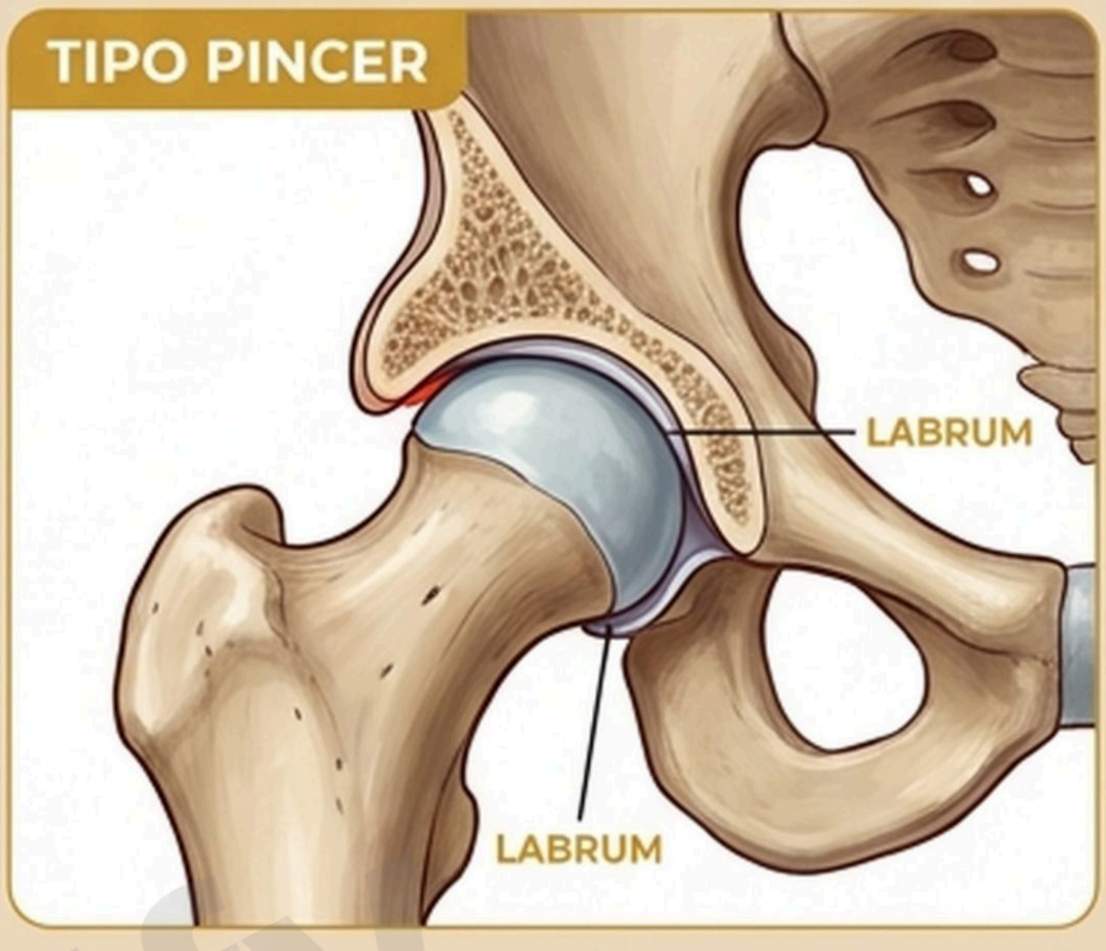
El manguito rotador y los estabilizadores escapulares mantienen la cabeza del húmero centrada en la cavidad glenoidea. Estabilidad antes que rango.

EN LA SALA

La alumna que, al tomarse las manos por detrás de la espalda, el hombro se le va completamente hacia adelante por falta de control. Busca llegar a toda costa sin estabilizar.

CUANDO EL FRENO ES ÓSEO





A veces, la limitación en el rango de movimiento no es muscular, sino ósea.

El **pinzamiento femoroacetabular (FAI)** es una condición en la que la forma de los huesos de la cadera genera un choque prematuro entre ellos, usualmente en flexión y rotación interna.

Forzar un estiramiento más allá de este tope óseo no va a alargar ningún músculo; solo va a pellizcar y dañar el labrum (el fibrocartílago que bordea la cavidad) y el cartilago articular.

El dolor es agudo y profundo en la ingle. En este caso, estirar no solo no es la respuesta, sino que es la causa del problema. Es fundamental aprender a reconocer esta limitación y derivar a un profesional.

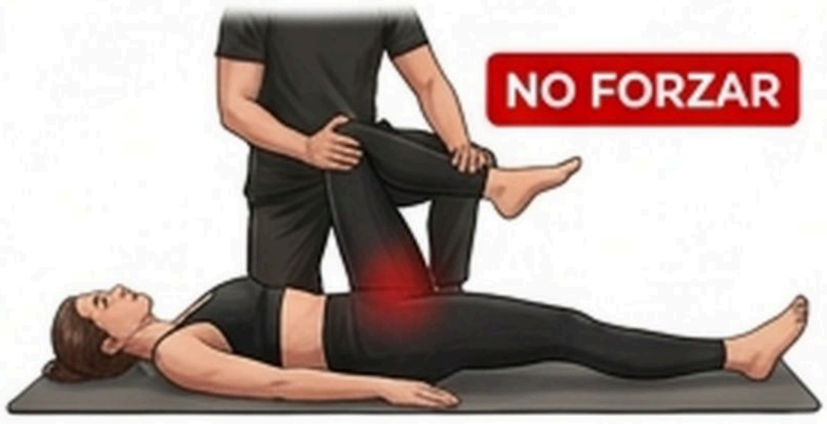
EN LA SALA

SÍNTOMA CLAVE



El alumno que siente un 'pinche' agudo y profundo en la ingle al llevar la rodilla al pecho, sin importar cuánto caliente.

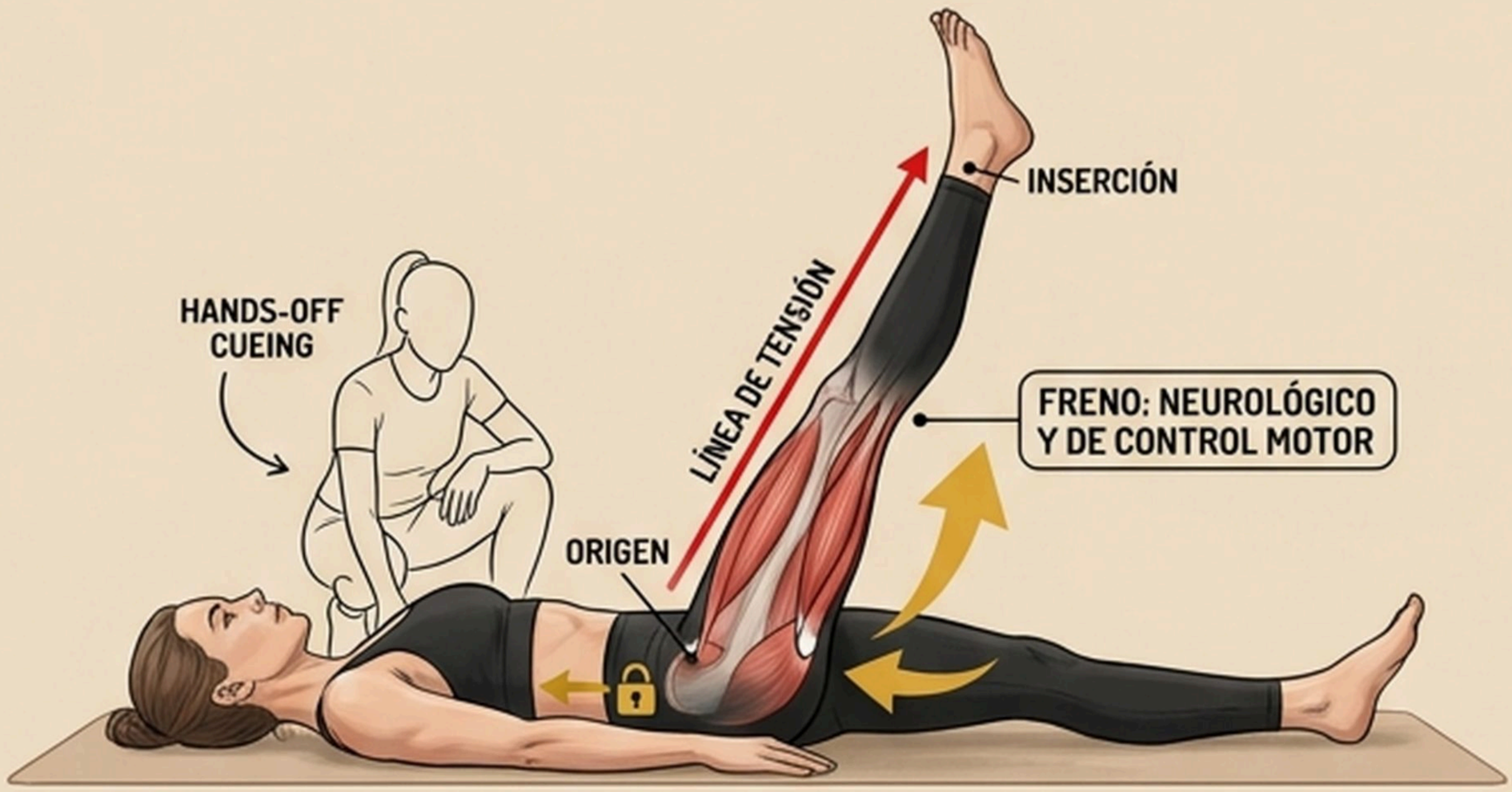
✕ QUÉ NO



Nunca se fuerza el estiramiento ante este tipo de dolor. La derivación médica es esencial.

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

FUERZA EN RANGO FINAL: ISQUIOTIBIALES





ISQUIOTIBIALES
INTENSIDAD 6
5-10 SE6 SOSTÉN
6-8 SERIES

PARA QUIÉN Para el alumno hiperlaxo que siente los isquiotibiales 'duros' pero tiene un rango pasivo enorme. Ideal para reemplazar el estiramiento pasivo sostenido. Busca activación y control.

EL ESTIRAMIENTO

- **MÉTODO:** Contracción activa en rango final.
- **TIEMPO:** Sostener 5-10 segundos por repetición.
- **RESPIRACIÓN:** Exhalar al subir la pierna, respirar suavemente mientras se sostiene.
- **INTENSIDAD:** 5-7/10 (el esfuerzo de sostener la pierna). 6-8 repeticiones por pierna. nuevo sostienes.
- **FIJO:** La pelvis y la columna lumbar no se mueven. La rodilla de la pierna de base no se flexiona.

PASO A PASO

1. 
Desde la posición inicial, prosioná el talón de la pierna de base contra el piso.

2. 
Exhalando, levantá lentamente una pierna extendida tan alto como puedas sin que se flexione la redilla ni se mueva la pelvis (aprox. 5 seg).

3. 
Sostené la pierna en el punto más alte usando solo tu fuerza muscular por 5-10 segundos.

4. 
Inhalando, bajá la pierna de forma controlada, más lento que al subir (aprox. 5 seg).

5. 
Repetí 8-8 veces.

ERRORES QUE VES EN LA SALA


La pelvis se va a retroversión y la lumbar se aplasta contra el piso (corregir: mantener el neutro pélvico, subir menos).


La rodilla de la pierna que sube se flexiona (corregir: activar el cuádriceps, subir menos).


Se toma impulso para subir (corregir: movimiento lento y controlado).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** Sí, es ideal.
- ✓ **Hernia (lumbar):** Sí, con control y sin dolor.
- ✓ **Rodilla operada:** Sí, si no hay dolor y la extensión es completa.
- ✗ **Embarazo:** Sí, es seguro.
- ✓ **Adulto mayor:** Sí, adaptando el rango.
- ✗ **Lesión reciente (isquiotibial):** No, esperar el alta kinesiológica.

REGRESIÓN

Hacerlo con la rodilla de base flexionada.

PROGRESIÓN

Agregar una pequeña carga en el tobillo (1kg).

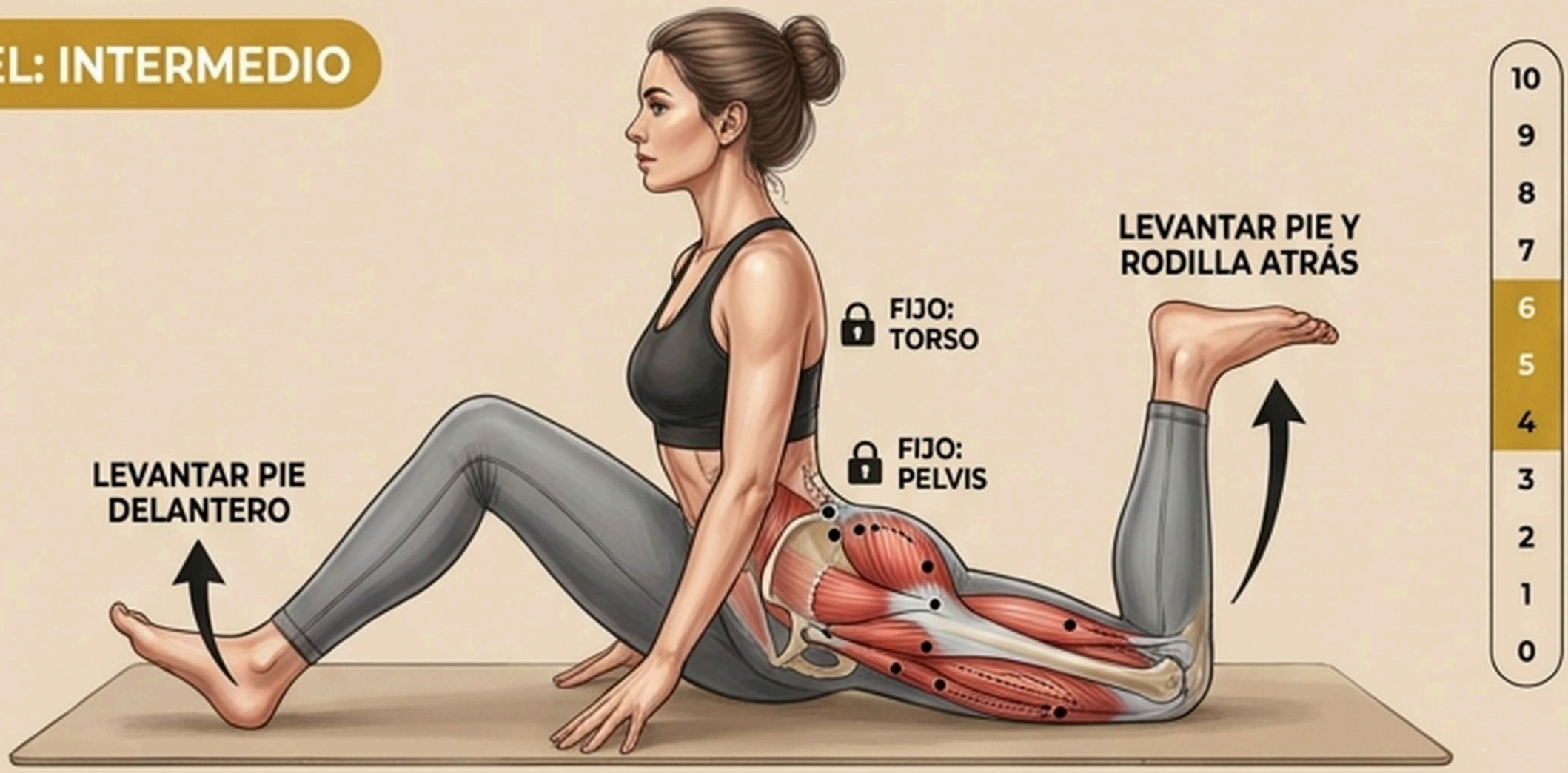
PARA SU CASA

"Buscá que el esfuerzo venga de la parte de adelante de tu cadera y tu muslo, y senti cómo la parte de atrás se alarga activamente. Menos es más, priorizá el control sobre la altura". **NIVEL:** Básico-Intermedio.

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

CONTROL DE CADERA EN 90/90 ACTIVO

NIVEL: INTERMEDIO



ROTADORES · INTENSIDAD 5-6 · 8-10 REPETICIONES POR LADO · 2-3 SEG SOSTÉN · 3 SERIES

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para la alumna hiperlaxa que necesita mejorar el control activo de la rotación interna y externa de la cadera. Busca aumentar la fuerza en los rangos finales sin perder la estabilidad.

EL ESTIRAMIENTO

- **MÉTODO:** Levantamientos isométricos/activos
- **INTENSIDAD:** 5-6/10
- **REPETICIONES:** 8-10 por lado, sostener 2-3 seg
- **RESPIRACIÓN:** Exhalar al levantar, inhalar al bajar

PASO A PASO



1. En posición 90/90, mantené el torso erguido, podés ayudarte con las manos en el piso.



2. Exhalando, intentá levantar el tobillo de la pierna de adelante del piso, sin mover la rodilla ni inclinar el torso. Sostené 2-3 seg. y bajá controlado. Repeti 8-10 veces.



3. Ahora, con la pierna de atrás, exhalando intentá levantar el pie y la rodilla del piso al mismo tiempo. Sostené 2-3 seg. y bajá. Repeti 8-10 veces.



4. Cambiá de lado y repetí el proceso con la otra pierna.

ERRORES QUE VES EN LA SALA



Inclinarse hacia el lado contrarie para levantar la pierna (corregir: mantener el torso vertical, levantar menos).



Usar el envión en vez de la fuerza muscular (corregir: movimiento lento y con pausas).



Dejar que la pelvis se mueva (corregir: pensar en anclar los isquiones al piso).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ **Hipermovilidad:** Sí, excelente.
✅ **Hernia (lumbar):** Sí, con la espalda recta y sin dolor.
✅ **Rodilla operada:** Consultar, la rotación puede ser sensible.
✅ **Embarazo:** Sí, en los primeros trimestres, luego puede ser incómodo.
✅ **Adulto mayor:** Sí, con apoyo y rango reducido.
❌ **Lesión reciente (cadera):** No, esperar alta profesional.

PARA SU CASA: "Imaginá que tus caderas son dos faros que siempre apuntan hacia adelante. El movimiento es pequeño y profundo, buscamos despertar los músculos que rodean la articulación".

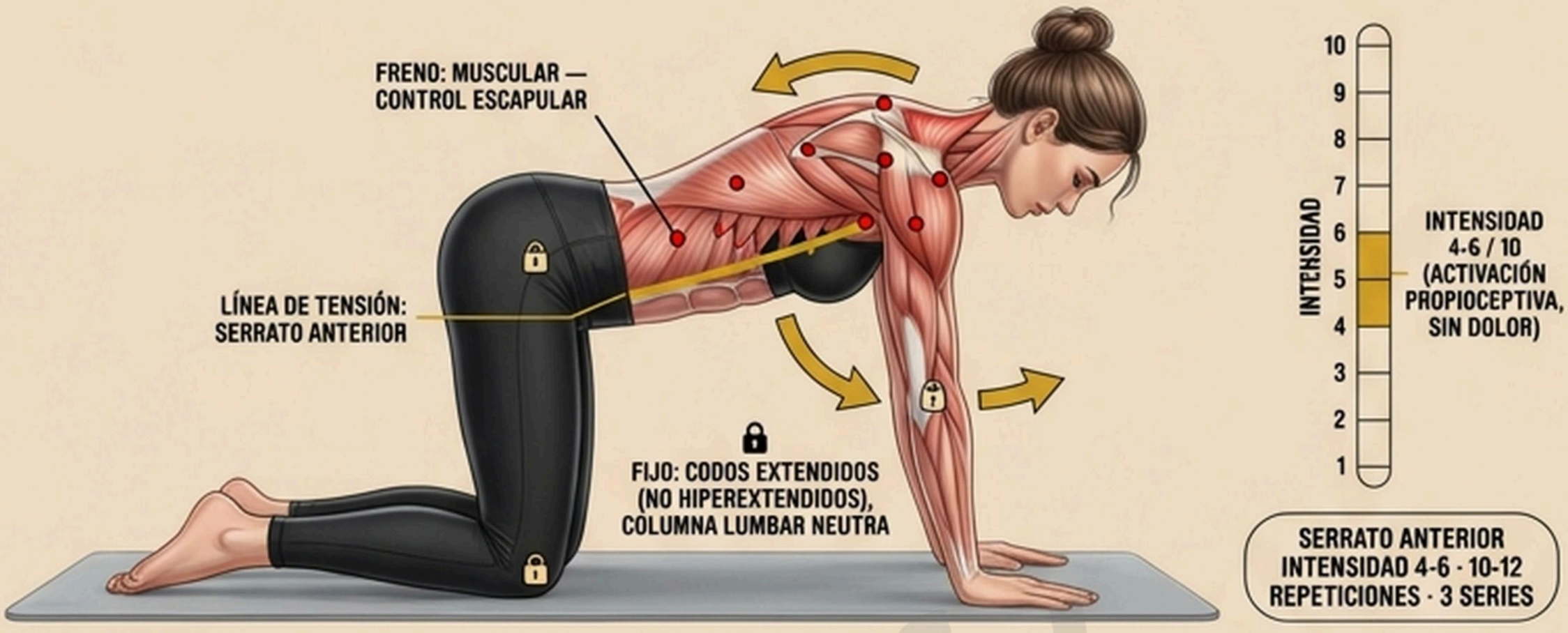
REGRESIÓN: Usar las manos en el piso para mayor estabilidad. Reducir el rango o hacer solo la intención de levantar.

PROGRESIÓN: Hacer el ejercicio sin apoyo de manos, brazos cruzados al pecho.

ESTABILIDAD DE HOMBRO EN APOYO: ACTIVACIÓN DE SERRATO ANTERIOR

CAPÍTULO: HOMBROS

NIVEL BÁSICO



SERRATO ANTERIOR
INTENSIDAD 4-6 · 10-12 REPETICIONES · 3 SERIES

PARA QUIÉN Para el alumno con hombros laxos o inestables, para enseñar a activar la musculatura estabillzadora en posiciones de carga como planchas o perro boca abajo. Busca mejorar el control motor escapular y el centrado de la articulación glenohumeral.

EL ESTIRAMIENTO

METODO: Activación propioceptiva y de estabilidad.
INTENSIDAD: 4-6/10.
REPETICIONES: 10-12 protracciones/retracciones.
RESPIRACIÓN: Exhalar al empujar el piso (protracción), inhalar al juntar escápulas (retracción).
SE MANTIENE FIJO: Los codos siempre extendidos (pero no hiperextendidos), la columna lumbar neutra.

PASO A PASO

1. En cuatro apoyos (cuadrupedia), mantené los brazos extendidos con muñecas debajo de los hombros y rodillas debajo de las caderas.
2. Inhalando, dejá que el pecho baje lentamente entre los brazos, juntando las escápulas (retracción escapular). Los codos no se flexionan.
3. Exhalando, empujá el piso con fuerza, como si quisieras separarlo, redondeando la parte alta de la espalda y separando las escápulas (protracción).
4. Sentí cómo se activa el músculo debajo de la axila (serrato anterior) al empujar.
5. Alterná los dos movimientos de forma lenta y controlada 10-12 veces.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Flexionar los codos (**CORREGIR**: el movimiento es solo de las escápulas, brazos rectos).
2. Hiperextender los codos (**CORREGIR**: mantener una microflexión, "desbloquear" la articulación).
3. Quebrar la cintura (**CORREGIR**: mantener el abdomen activo para estabilizar la zona lumbar, evitando arquear).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **HIPERMOVILIDAD:** Sí, fundamental para la estabilidad.
- ✓ **HERNIA (CERVICAL/LUMBAR):** Sí, con control y sin dolor.
- ✕ **MUÑECA OPERADA:** No, buscar alternativas sin apoyo directo.
- ✓ **EMBARAZO:** Sí, en los primeros meses con precaución.
- ✕ **ADULTO MAYOR:** Sí, se puede hacer contra la pared.
- ✕ **LESIÓN RECIENTE (HOMBRO):** No, esperar el alta médica.

REGRESIÓN (Más fácil): Hacer el mismo movimiento de pie, con las manos apoyadas en una pared, enfocando en el movimiento escapular.

PROGRESIÓN (Más difícil): Realizar el movimiento en posición de plancha alta, manteniendo la alineación corporal.

PARA SU CASA (Qué le decís al alumno): "No te hundas sobre tus hombros. La idea es que te vuelvas fuerte para empujar el mundo lejos de vos. Sentí cómo tus omóplatos se deslizan sobre las costillas".

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

CADENA POSTERIOR CON CARGA

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para la alumna hiperlaxa que necesita fortalecer toda la cadena posterior (glúteos, isquiotibiales, espalda baja) de forma integrada y controlada.

POSICIÓN DE PARTIDA

De pie, pies ancho de caderas, con una pesa rusa (o mancuerna) sostenida con ambas manos.

ZONA Y MÚSCULOS

Glúteo mayor, isquiotibiales, erectores espinales.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Ejercicio de fuerza (peso muerto rumano).
Intensidad: 6-8/10 (depende de la carga).
Repeticiones: 8-12.
Respiración: Inhalar al bajar, exhalar al subir.
Qué se mantiene fijo: La columna en posición neutra, sin redondear ni hiperextender.

PASO A PASO

1. De pie, con una leve flexión en las rodillas (no trabadas). La espalda larga.
2. Inhalando, iniciá el movimiento llevando la cadera hacia atrás, como si quisieras tocar una pared con la cola (bisagra de cadera).
3. El torso se inclina hacia adelante, manteniendo la espalda recta. La pesa baja cerca de las piernas.
4. Bajá hasta que sientas una tensión moderada en los isquiotibiales o hasta que la espalda no pueda mantenerse neutra.
5. Exhalando, empujá el piso con los pies y contraé los glúteos para volver a la posición inicial.
6. Repeti 8-12 veces.

3 ERRORES COMUNES

1. Redondear la espalda para bajar más (**carregir**: mantener el pecho abierto, bajar menos).
2. Flexionar demasiado las rodillas, convirtiéndolo en una sentadilla (**corregir**: el movimiento principal es la cadera hacia atrás).
3. Hiperextender la lumbar al final del movimiento (**cerregir**: terminar en una linea recta, glúteos apretados).



REGRESIÓN:

Hacer el movimiento sin peso (Good mornings).

PROGRESIÓN:

Aumentar la carga
Hacerlo a una pierna.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ☑ **Hipermovilidad:** Sí, con foco en el control y no en el rango.
- ☑ **Hernia (lumbar):** Con precaución, sin dolor y con técnica perfecta.
- ☑ **Rodilla operada:** Sí, si la flexo-extensión es estable.
- ✗ **Embarazo:** No, por la presión intraabdominal.
- ✗ **Adulto mayor:** Sí, con poca o ninguna carga.
- ✗ **Lesión reciente (isquiotibial):** No, hasta el alta funcional.

PROGRESIÓN:

Aumentar la carga progresivamente. Hacerlo a una pierna.

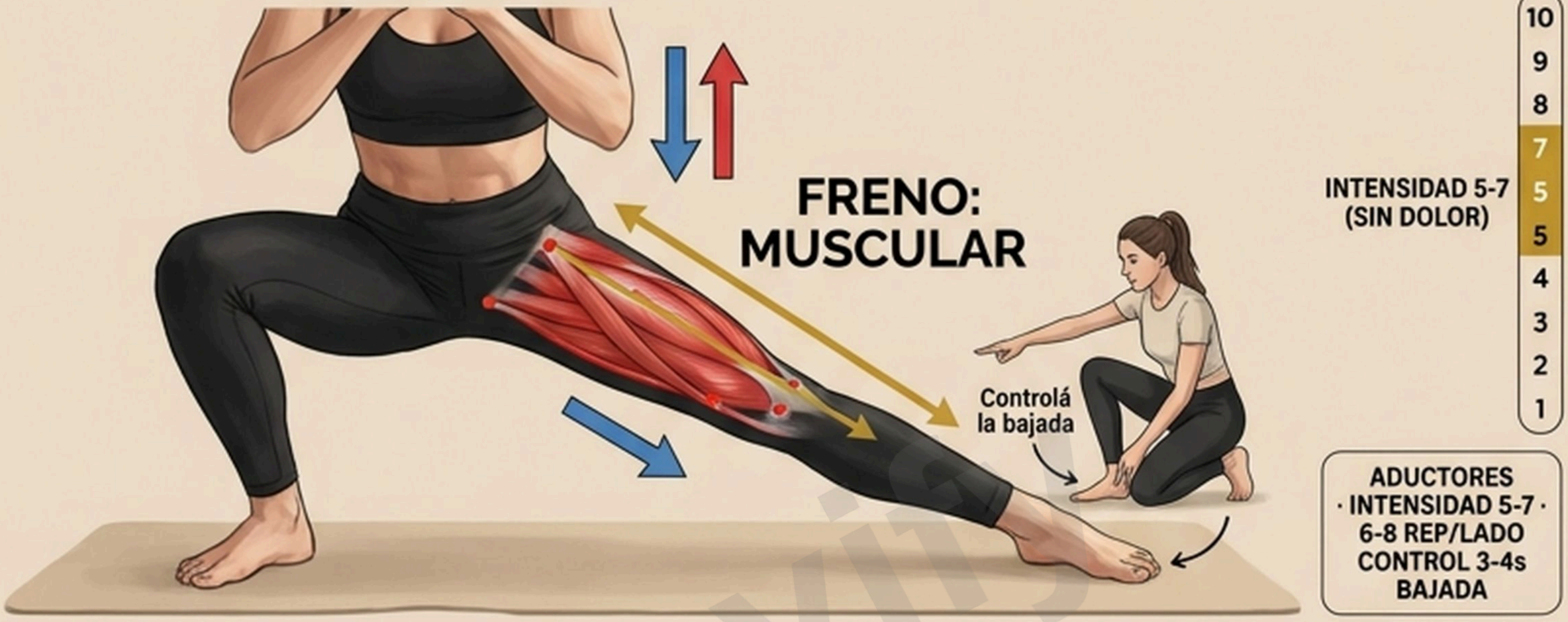
QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA

"Pensá que el motor del movimiento es tu cadera yendo hacia atrás. Tu espalda es un bloque sólido que solo acompafia. Al subir, el empuje viene de tus glúteos".

NIVEL: Intermedio.

ADUCTORES CON CONTROL EXCÉNTRICO: FORTALECIMIENTO Y ESTIRAMIENTO ACTIVO PARA HIPERLAXITUD

NIVEL INTERMEDIO · CONTROL EXCÉNTRICO · PREVENCIÓN DE PUBALGIA



PARA QUIEN Y EN QUE SITUACION

Para el alumno hiperlaxo con tendencia a la pubalgia o debilidad en aductores, para fortalecerlos en alargamiento y mejorar la estabilidad pélvica

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Desplazamiento lateral controlado (Cossack squat). **INTENSIDAD:** 5-7/10. **REPETICIONES:** 6-8 por lado.
RESPIRACIÓN: Inhalar al bajar, exhalar al subir.
QUÉ SE MANTIENE FIJO: El pie de la pierna extendida se mantiene completamente apoyado en el piso. La espalda, neutra

PASO A PASO

1. Desde la posición de partida (pies separados más que ancho de hombros), comenzá a flexionar una rodilla y a desplazar el peso de tu cuerpo hacia ese lado.
2. La otra pierna se mantiene extendida. Mantené el talón de la pierna extendida en el suelo.
3. Bajá de forma controlada (3-4 segundos) hasta donde sientas un estiramiento en el aductor de la pierna extendida, sin que se levante el talón ni se curve la espalda.
4. Exhalando, empujá desde el pie de la pierna flexionada para volver al centro de forma potente.
5. Alterná de lado o completá las repeticiones de un lado antes de cambiar

ERRORES QUE VES EN LA SALA



Levantar el talón de la pierna extendida (CORRECCIÓN: bajar menos, mantener el pie anclado).

Dejar que la rodilla flexionada colapse hacia adentro (CORRECCIÓN: alinear la rodilla con la punta del pie).

Inclinar el torso demasiado hacia adelante (CORRECCIÓN: mantener el pecho erguido)

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ **HIPERMOVILIDAD:** Sí, es un gran ejercicio.
✅ **HERNIA (LUMBAR):** Sí, con buena técnica y sin dolor.
✅ **RODILLA OPERADA:** Con precaución, controlar la flexión.
❌ **EMBARAZO:** Sí, adaptando la profundidad.
❌ **ADULTO MAYOR:** Sí, con rango reducido y posible apoyo.
❌ **LESIÓN RECIENTE (ADUCTOR/PUBIS):** No, esperar alta profesional

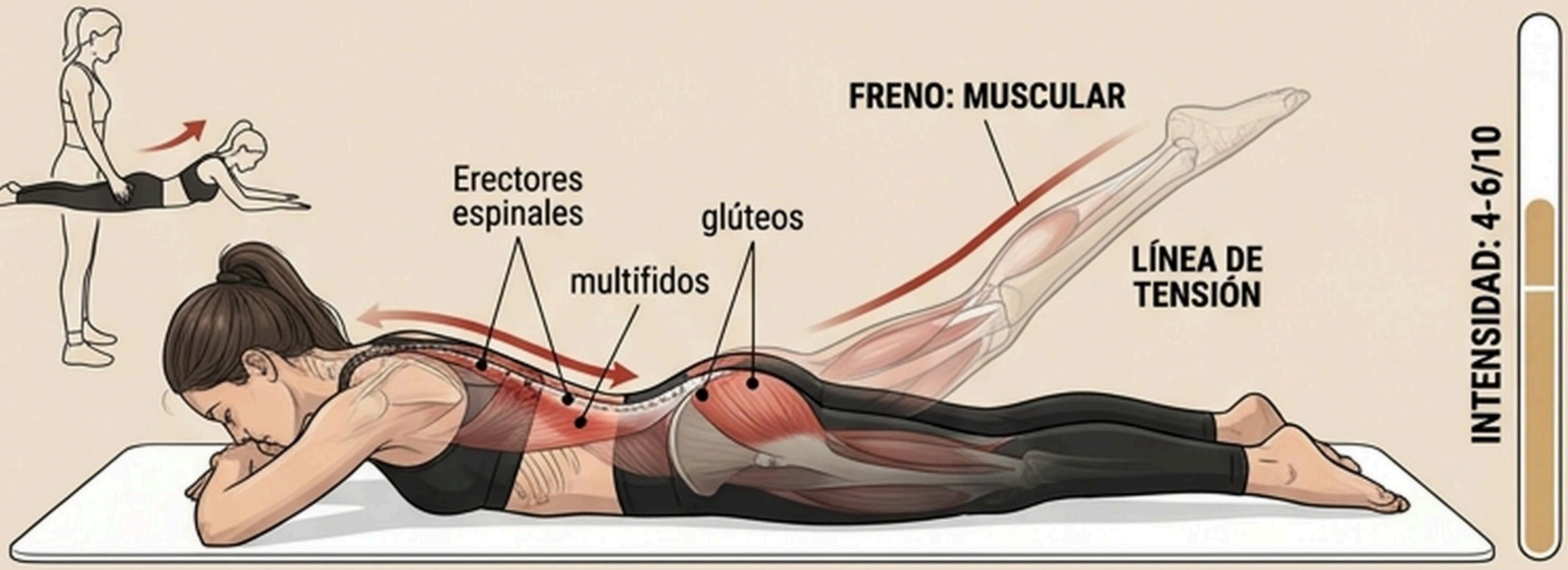
REGRESIÓN: Reducir la separación de los pies y la profundidad del movimiento. Usar un apoyo

PROGRESIÓN: Sostener una pesa en el pecho. Bajar más profundo si la técnica lo permite

PARA SU CASA (ALUMNO): "Controlá la bajada, sentí cómo el músculo de la ingle se estira mientras trabaja. La subida es tu momento de potencia".

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

EXTENSIÓN DE COLUMNA CON CONTROL



PARA QUIÉN

Para la alumna hiperlaxa que tiende a "quebrarse" en la zona lumbar en las extensiones, en vez de hacer un puente o una cobra pasiva.
POSICIÓN DE PARTIDA: Acostada boca abajo (decúbito prono), con la frente apoyada en las manos, piernas extendidas y relajadas.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Extensión activa de columna (Superman).
Intensidad: 4-6/10.
Tiempo: Sostener 3-5 segundos arriba. 10-12 repeticiones.
Respiración: Exhalar al subir, inhalar al bajar.
Qué se mantiene fijo: El pubis debe mantenerse en contacto con el piso. El cuello sigue la línea de la columna.

PASO A PASO

1. Desde la posición de partida, activá suavemente los glúteos y el abdomen, como si quisieras levantar el ombligo del piso.
2. Exhalando, levantá la cabeza, los hombros y el pecho del piso, despegando también las manos. La mirada va al piso, un poco por delante.
3. El movimiento debe ser lento y la sensación de trabajo repartida en toda la espalda, no solo en la cintura.
4. Sostené la posición arriba por 3-5 segundos.
5. Inhalando, bajá con el mismo control.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Usar el cuello para subir, mirando al frente (corregir: mantener el cuello largo, como una extensión de la espalda).
2. Sentir un pinzamiento en la zona lumbar (corregir: subir menos, activar más el abdomen y los glúteos).
3. Levantar las piernas, a menos que sea una progresión intencional (corregir: mantener las piernas relajadas y ancladas).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad: Sí (alternativa segura).
Hernia (lumbar): Con extrema precaución, solo si no hay dolor y está indicado.
Rodilla operada: Sí.
Embarazo: No (posición prono).
Adulto mayor: Sí (con rango muy limitado).
Lesión reciente (espalda): No, esperar el alta.

REGRESIÓN: Levantar solo la cabeza y los hombros, sin las manos.

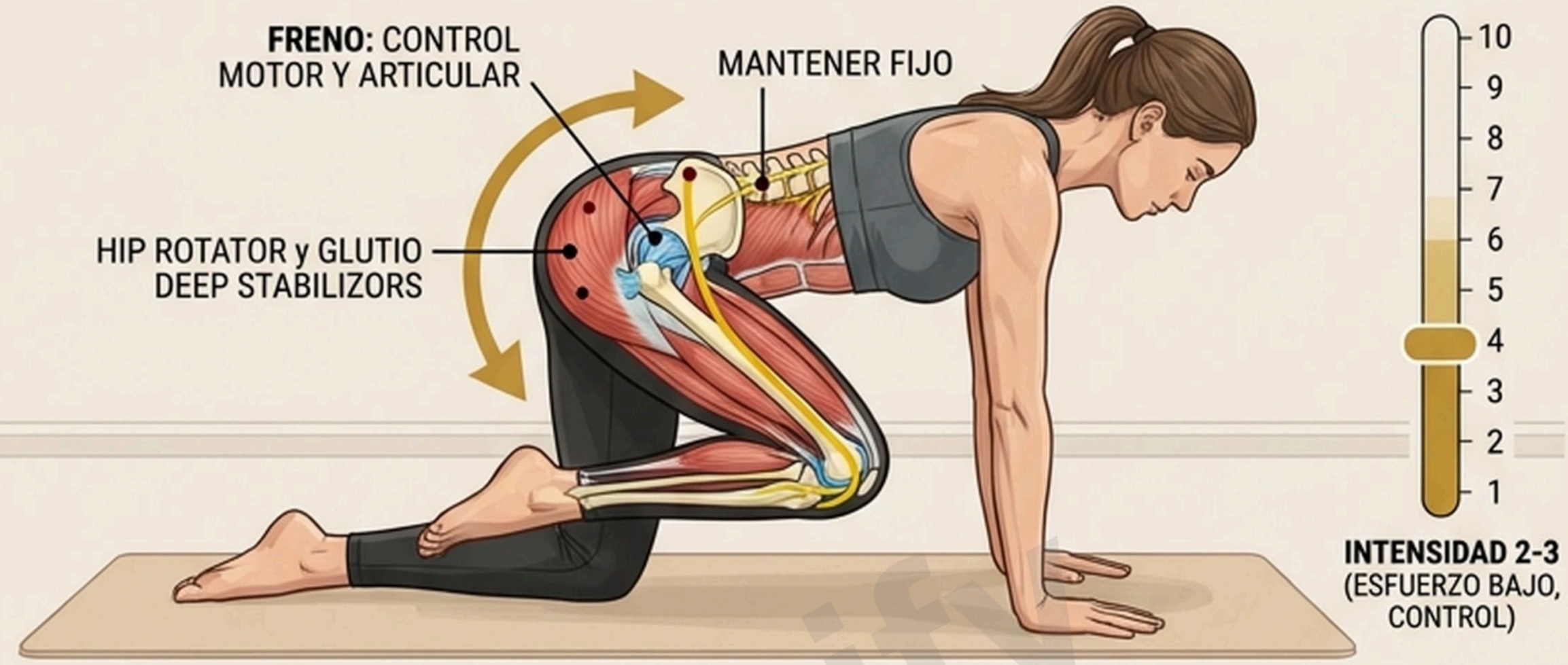
PROGRESIÓN: Extender los brazos hacia adelante (posición de Superman).

PARA SU CASA: "Imaginá que te alargás hacia adelante antes de subir. Buscá una curva larga y suave en tu espalda, no un quiebre en la cintura".

NIVEL: Básico

ROTACIONES CONTROLADAS (CARs)

NIVEL: BÁSICO



PARA QUIÉN Para todo alumno, pero especialmente para el hiperlaxo, para enseñar al sistema nervioso a controlar el rango de movimiento de una articulación de forma aislada.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Rotaciones Articulares Controladas (CARs).
Intensidad: 2–3/10. **Repeticiones:** 3–5 círculos lentos por lado y por sentido.
Respiración: Fluida y constante. **Qué se mantiene fijo:** El resto del cuerpo. La clave es la disociación.

PASO A PASO (CADERA)

1. **En cuatro apoyos**, abdomen firme, lumbar fija.
2. **Llevá una rodilla al pecho** (flexión).
3. **Abrí la rodilla hacia el costado** (abducción).
4. **Rotá la cadera, pie al techo** (rotación externa).
5. **Pierna atrás** (extensión), volvé al inicio.
6. **Movimiento grande y lento**, sin compensar.
7. **Repetí en sentido contrario**.





3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Mover columna o pelvis** (corregir: reducir círculo, aumentar tensión core).
2. **Hacerlo rápido y con impulso** (corregir: lentitud es clave, como en miel espesa).
3. **Dejar de respirar** (corregir: mantener respiración constante).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hipermovilidad:** Sí, base del control.
- Sí, con control abdominal.
- **Hernia:** Sí,
- **Rodilla/Hombro operado:** Sí, en rangos sin dolor.
- **Embarazo:** Sí, excelente.
- **Adulto mayor:** Sí, excelente.
- Sí, excelente.
- **Lesión reciente:** Sí, en rango mínimo sin dolor.

REGRESIÓN

Hacer círculos más pequeños

PROGRESIÓN

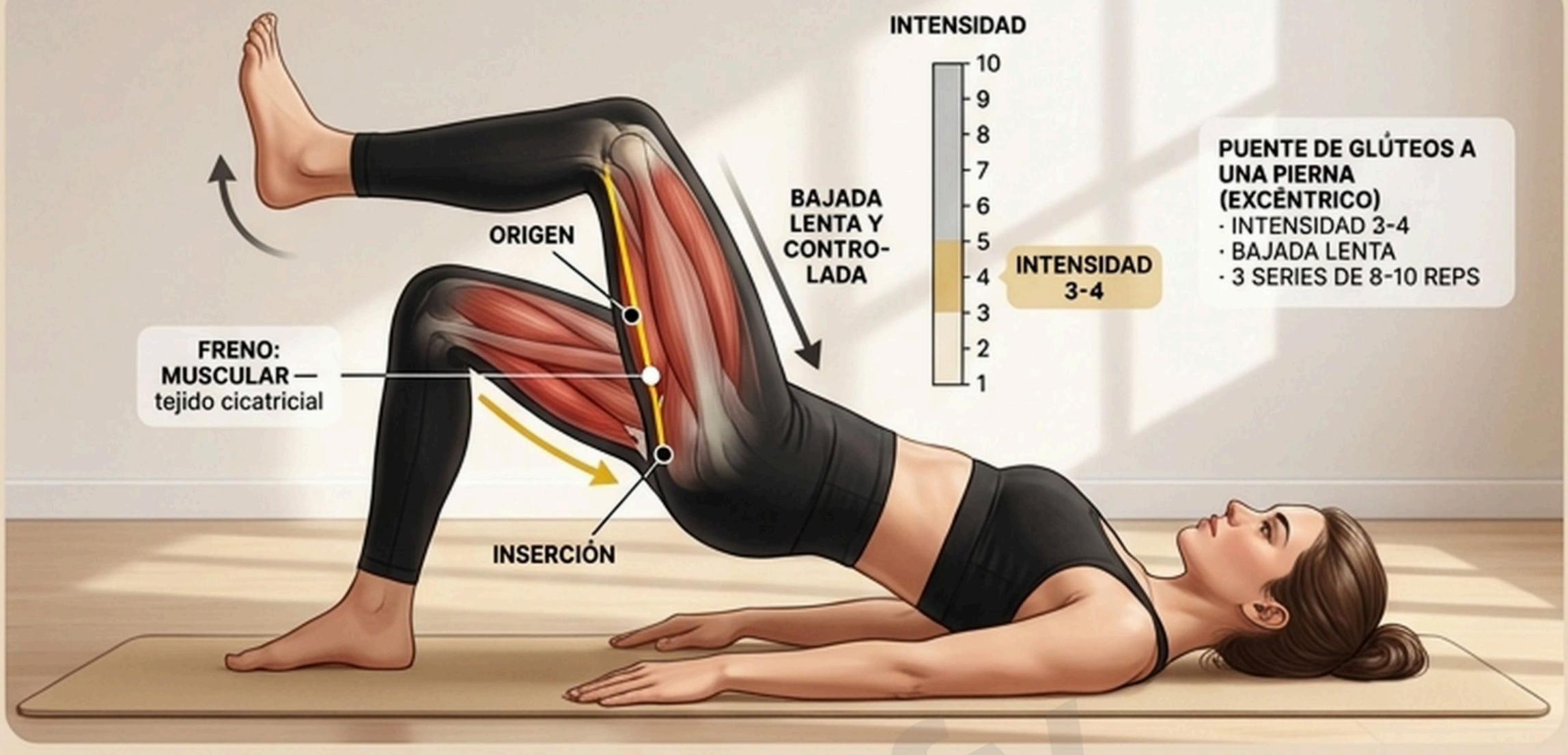
Aumentar tensión de irradiación para mejor aislamiento

PARA SU CASA

'Explorá el límite de tu movimiento sin dolor, dibujando el circulo perfecto con el resto del cuerpo inmóvil'

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

RETORNO POST DESGARRO ISQUIOTIBIAL



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para la alumna que tuvo un desgarro de isquiotibial, recibió el alta kinesiológica y quiere volver a la práctica de forma segura.

EL OBJETIVO: Reintroducir la tensión en el tejido de forma gradual y controlada, promoviendo la alineación de las nuevas fibras de colágeno.

QUÉ SÍ (bajo supervisión profesional)

- **1. ISOMÉTRICOS SIN DOLOR:** Empezar con contracciones suaves sin movimiento (ej: empujar el talón contra el piso desde una posición semisentada).



- **2. RANGO DE MOVIMIENTO ACTIVO:** Movimientos suaves y controlados de flexo-extensión de rodilla sin carga y sin llegar al límite.



- **3. CARGA EXCÉNTRICA MUY GRADUAL:** Ejercicios como puentes de glúteos a una pierna con bajada muy lenta, o pesos muertos rumanos con poquisimo peso.
- **4. ESTIRAMIENTOS DINÁMICOS SUAVES:** Balanceos controlados de la pierna hacia adelante, siempre lejos del punto de dolor.



QUÉ NO (en las primeras etapas)

- **1. ESTIRAMIENTO ESTÁTICO PASIVO:** Totalmente contraindicado. Sostener un estiramiento en el isquiotibial puede volver a dafiar el tejido cicatricial que es frágil.



- **2. ESTIRAMIENTOS BALÍSTICOS O CON REBOTE:** Pueden causar una re-lesión inmediata.



- **3. FLEXIONES PROFUNDAS:** Evitar posturas que lleven al isquiotibial a su máximo alargamiento, especialmente si comprimen el tendón proximal (como flexiones sentadas).



PASO A PASO PARA VOLVER

1. **Fase 1 (post-alta):** Foco en isométricos y movilidad activa sin dolor.
2. **Fase 2:** Introducir carga excéntrica y concéntrica muy liviana, siempre en rango medio.
3. **Fase 3:** Aumentar progresivamente la carga y el rango, introduciendo estiramientos dinámicos.
4. **Fase 4:** Reintroducir estiramientos estáticos suaves (30 seg, intensidad 3-4/10) solo cuando la fuerza sea simétrica con la otra pierna y no haya dolor.

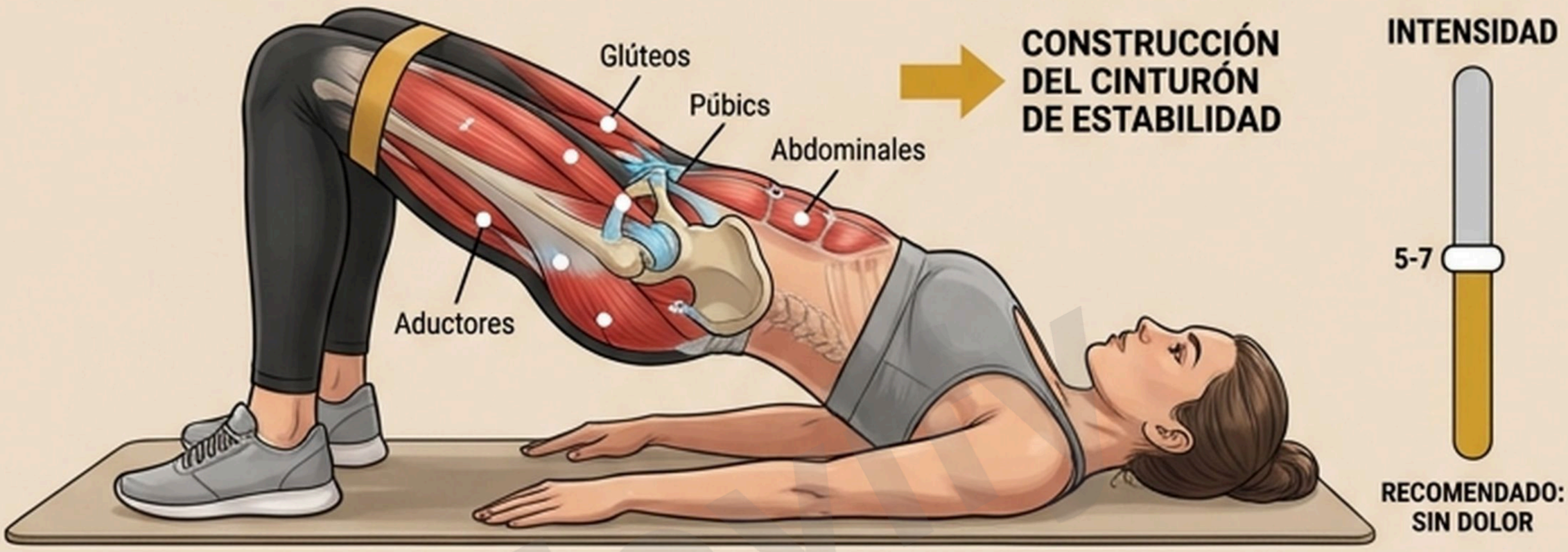
QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA

'Tu músculo no necesita que lo estires pasivamente ahora. Necesita que le enseñes a ser fuerte y resistente de **nuevo**. Vamos a ir muy de a poco, la paciencia es tu mejor aliada. El dolor es el limite absoluto'.

RETORNO POST PUBALGIA

RETORNO POST PUBALGIA: ESTABILIDAD PÉLVICA Y PROGRESIÓN SEGURA

PARA QUIÉN: Alumno diagnosticado con pubalgia (dolor en sínfisis púbica), con alta para retomar actividad.
EL OBJETIVO: Fortalecer la musculatura que estabiliza la pelvis (aductores, abdominales, glúteos) sin irritar la sínfisis.



QUÉ SÍ (BAJO SUPERVISIÓN)

1. **ISOMÉTRICOS DE ADUCTORES:** Apretar pelota entre rodillas, 5-10 seg, sin dolor.
2. **FORTALECIMIENTO DEL CORE:** Planchas, bicho muerto para estabilidad lumbopélvica.
3. **ACTIVACIÓN DE GLÚTEOS:** Puentes, abducción de cadera con banda.
4. **MOVIMIENTOS CONTROLADOS:** Sentadillas y estocadas con rango limitado y técnica perfecta.

QUÉ NO (HASTA QUE NO HAYA DOLOR)

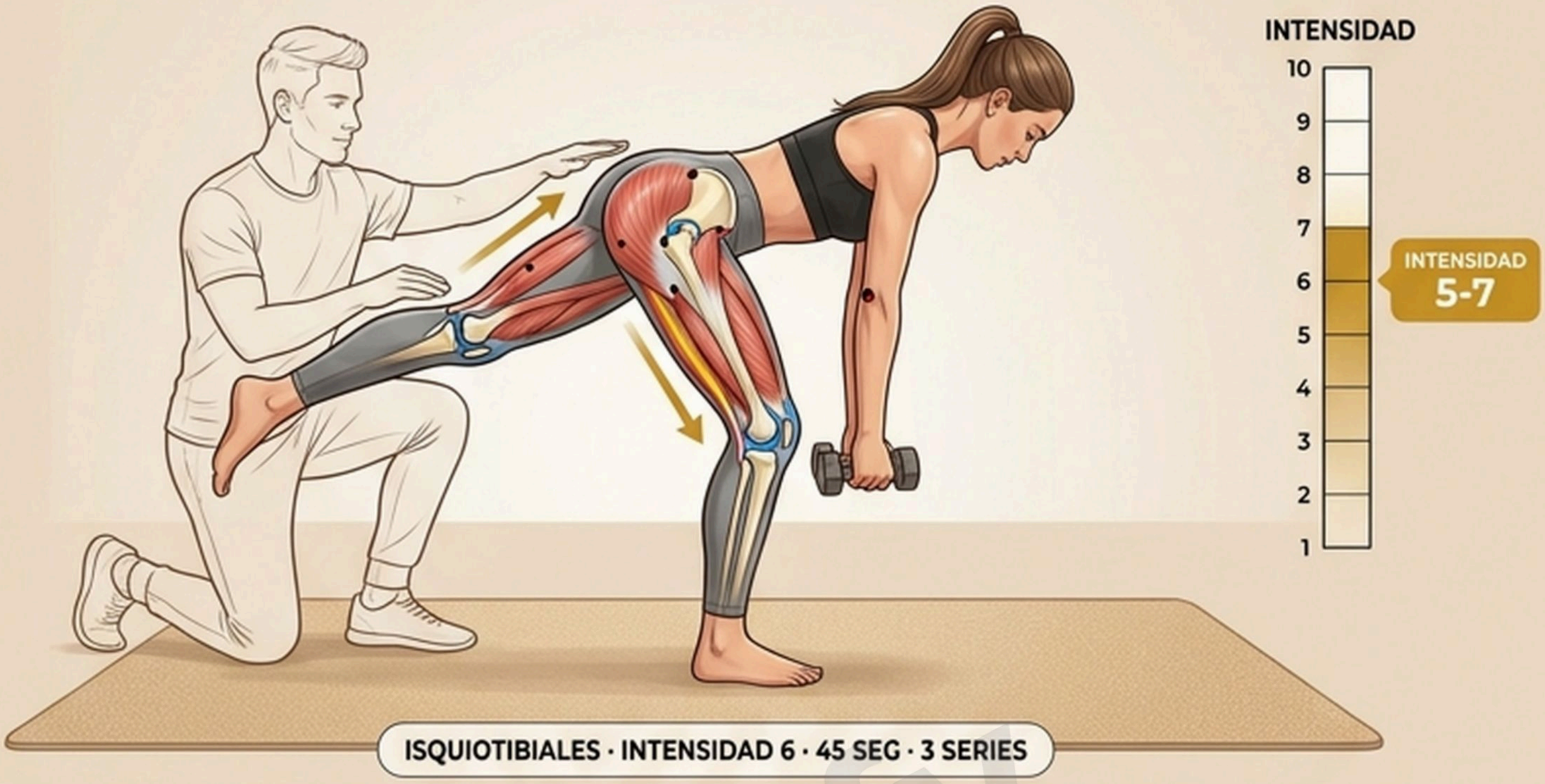
1. **ESTIRAMIENTOS DE ADUCTORES EN APERTURA MÁXIMA:** Evitar "mariposa", "rana" o aperturas amplias.
2. **CAMBIOS DE DIRECCIÓN BRUSCOS O SALTOS:** No pliométricos ni movimientos explosivos laterales.
3. **EJERCICIOS A UNA PIERNA CON INESTABILIDAD:** Evitar cizallamiento pélvico al inicio.

PASO A PASO PARA VOLVER: PROGRESIÓN GRADUAL

FASE 1 (POST-ALTA): Isométricos aductores, activación core y glúteos. → **FASE 2:** Introducir fuerza cadena cerrada (sentadillas, puentes) rango controlado. → **FASE 3:** Progresar carga, movimientos a una pierna muy estables. → **FASE 4:** Reintroducir movimientos dinámicos y estiramientos suaves, escuchando al cuerpo.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO: "Tu pelvis necesita estabilidad. Vamos a construir un cinturón de músculos fuertes a su alrededor. Olvidate por ahora de las aperturas extremas; el foco es la fuerza y el control. Si duele, paramos".

RETORNO POST TENDINOPATÍA



RETORNO POST TENDINOPATÍA:
CARGA ÓPTIMA Y PROGRESIVA

☑ PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para la alumna con diagnóstico de tendinopatia (ej: isquiotibial proximal, glúteo medio) que tiene el alta kinesiológica para volver a entrenar.
EL OBJETIVO: Aplicar una carga óptima y progresiva al tendón para estimular la remodelación del colágeno sin aumentar la irritación.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ QUÉ SÍ (es la base del tratamiento)

1. **ISOMÉTRICOS DE LARGA DURACIÓN:** Contracciones sostenidas (30-45 segundos) en una posición que no comprima el tendón, con una intensidad moderada (5-7/10). A menudo tienen un efecto analgésico. (Ej: puente isométrico para tendinopatia de isquiotibial).
2. **EJERCICIOS EXCÉNTRICOS LENTOS:** Fase de alargamiento del músculo muy controlada (3-5 segundos). Ayudan a alinear las fibras de colágeno. (Ej: fase de bajada en un peso muerto rumano a una pierna).
3. **FORTALECIMIENTO GENERAL:** Trabajar toda la cadena cinética para reducir la carga sobre el tendón afectado.

❌ QUÉ NO (especialmente si hay compresión)

1. **ESTIRAMIENTO ESTÁTICO SOSTENIDO:** Especialmente en posiciones que comprimen el tendón contra el hueso (ej: flexión profunda sentada para tendinopatia de isquiotibial proximal; postura de la paloma para tendinopatia de glúteo medio).
2. **CARGA COMPRESIVA:** Evitar las posiciones que causaron o empeoran el dolor.
3. **ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO O VELOCIDAD:** Al principio, evitar saltos, sprints o movimientos balisticos que involucren al tendón afectado.

PASO A PASO PARA VOLVER

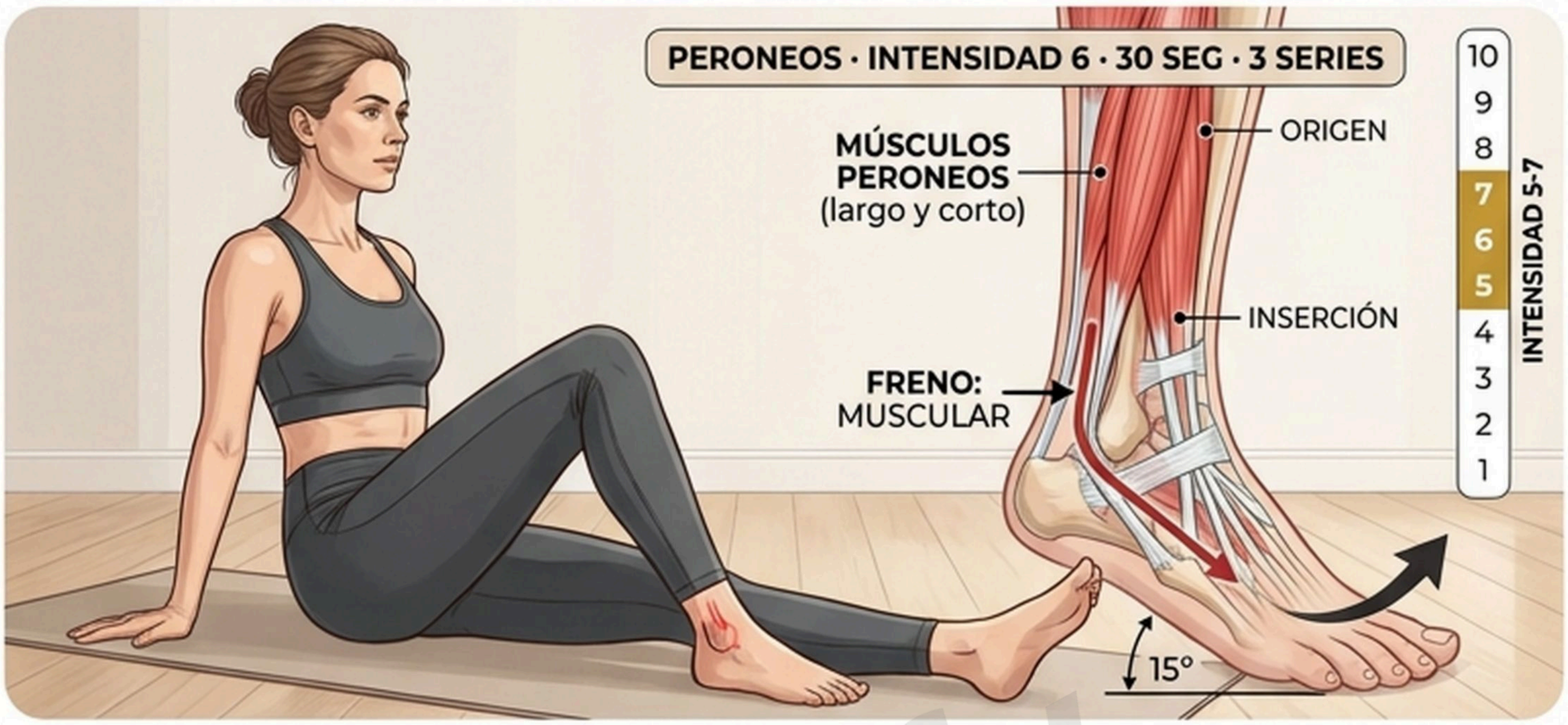
1. **Fase 1 (dolor agudo/reactivo, bajo supervisión):** Isométricos para calmar el dolor.
2. **Fase 2 (tendón menos reactivo):** Introducir ejercicios de fuerza con tempo lento (isométricos, excéntricos, concéntricos).
3. **Fase 3:** Aumentar la carga y la velocidad de forma muy gradual.
4. **Fase 4:** Reintroducir progresivamente los movimientos específicos de su disciplina.

💬 QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA

"Tu tendón no está 'corto', está sobrecargado y desorganizado. No vamos a estirarlo, vamos a cargarlo de forma inteligente para que se reconstruya más fuerte. La carga es su medicina".

BONO 2 · HIPERMOVILIDAD Y LESIONES

TOBILLO INESTABLE: MOVILIDAD Y CONTROL



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para el alumno con antecedentes de esguinces de tobillo a repetición o sensación de inestabilidad, muy común en hiperlaxos. Busca fortalecer los estabilizadores para mejorar la respuesta ante torceduras.

EL OBJETIVO

Mejorar la movilidad útil (especialmente la dorsiflexión) y el control motor y propioceptivo del tobillo y el pie.

QUÉ SÍ ✓

1. **MOVILIDAD ACTIVA:** Círculos de tobillo controlados, flexión y extensión, buscando el máximo rango sin compensar con el resto de la pierna.
2. **FORTALECIMIENTO DE LA MUSCULATURA PERONEA:** Ejercicios de eversión del pie, idealmente con una banda elástica.
3. **MEJORA DE LA DORSIFLEXIÓN:** Movilizaciones de rodilla al frente sobre el pie, sin levantar el talón.
4. **TRABAJO DE PROPIOCEPCIÓN Y EQUILIBRIO:** Mantener el equilibrio sobre una pierna, primero en superficie estable y luego inestable (almohadón).

QUÉ NO ✗

1. **ESTIRAMIENTO PASIVO FORZADO DE LOS LIGAMENTOS:** Evitar forzar la inversión del tobillo o cualquier posición que recuerde al mecanismo del esguince.
2. **ZAPATILLAS DEMASIADO ACOLCHADAS O INESTABLES:** Para el trabajo de propiocepción, es mejor estar descalzo o con calzado minimalista.
3. **IGNORAR EL DOLOR O LA SENSACIÓN DE FALLO:** Si el tobillo 'se va', es una señal para dar un paso atrás y trabajar en una progresión más simple.



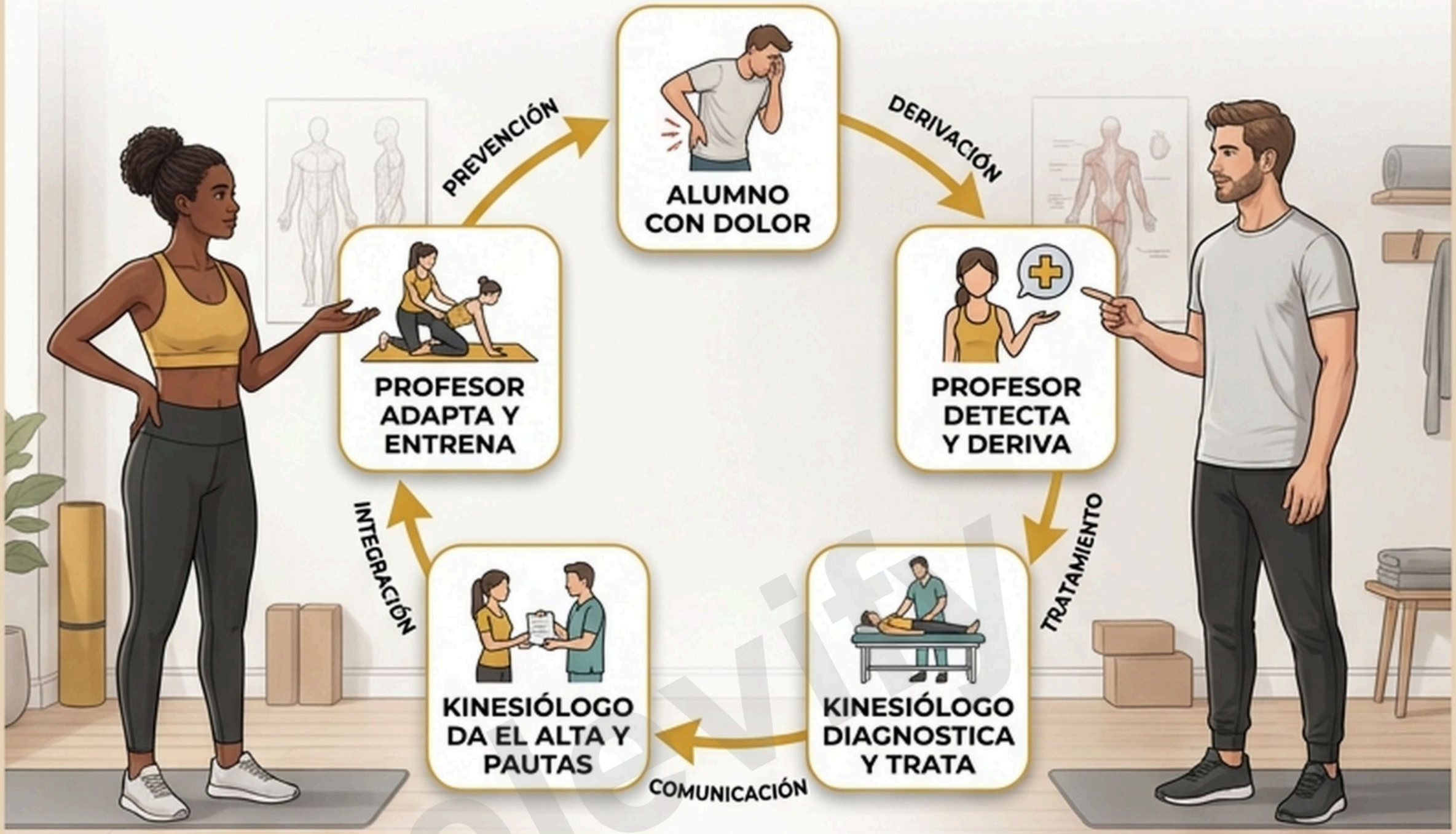
TEST RÁPIDO DE DORSIFLEXIÓN

De pie, frente a una pared, con un pie a unos 10-12 cm de distancia. Intentar tocar la pared con la rodilla sin levantar el talón. Si no llega, la dorsiflexión puede estar limitada, lo que puede llevar a compensaciones en la rodilla o la cadera.

CUE DE LA FORMADORA

"Tus tobillos son tus cimientos. No solo necesitamos que sean móviles, sino también inteligentes. Vamos a despertar los pequeños músculos que los estabilizan para que puedan reaccionar rápido y protegerte de futuros esguinces. Pensá en tener pies fuertes y sensibles".

TRABAJO EN EQUIPO



ROLES Y COMUNICACIÓN

Como profesor del movimiento, tu rol no es **diagnosticar** ni **tratar lesiones**, pero sí es fundamental saber reconocer las **banderas rojas** y cuándo **derivar** a un profesional de la salud.

Cuando un alumno llega con el alta kinesiológica, tu trabajo es la "**post-post-rehabilitación**". Es clave que puedas **comunicarte** con el **kinesiólogo** para entender el **diagnóstico**, saber qué **movimientos están permitidos** y cuáles hay que **evitar**.

Tu objetivo es integrar a esa persona a la clase de forma segura, aplicando las **adaptaciones** necesarias y reforzando el trabajo de **fuerza** y **control** que inició en el consultorio.

EN LA SALA



Mi kinesiólogo me dijo que ya podía volver, pero que no hiciera torsiones profundas



Perfecto, vamos a buscar alternativas para vos en esas posturas



80 pixels

QUÉ LE EXPLICÁS AL ALUMNO



CÓMO SE LO EXPLICÁS

La comunicación con la alumna hiperlaxa es clave para que entienda por qué le pedís cosas que van en contra de lo que siempre creyó que necesitaba.

Usá analogías simples. Podés decirle: “Imaginá que tus articulaciones son como bisagras muy sueltas. Si las forzamos más, se gastan. Lo que necesitamos es construir un marco de músculos fuertes alrededor para que se muevan de forma controlada y segura”.

Explicarle que su sensación de “rigidez” es una defensa de su cuerpo le da sentido a por qué el foco estará en la fuerza y no en el estiramiento pasivo. El objetivo es empoderarla con conocimiento sobre su propio cuerpo.

EN LA SALA

“Entiendo que te sientas dura y quieras estirar más, pero probemos esto: en vez de colgar en la postura, activá tus músculos para sostenerla. Vas a ver que la sensación de control te va a dar más seguridad y alivio a largo plazo”.



LA CLASE MIXTA

En una clase grupal vas a tener alumnos en ambos extremos del espectro de movilidad. La clave es dar indicaciones que sirvan para todos. En vez de enfocarte en “llegar más lejos”, poné el foco en la “calidad del movimiento”. Usá cues que promuevan la estabilidad para los hiperlaxos y que al mismo tiempo sean seguras para los más rígidos. Por ejemplo, en vez de “bajá todo lo que puedas”, decí “bajá hasta donde puedas mantener tu espalda larga y tu abdomen activo”. Ofrecé siempre regresiones y progresiones, y enseñá el uso de elementos (tacos, cintos) como herramientas para adaptar la postura a cada cuerpo, no como un signo de debilidad.



INTENSIDAD: 5-7 (MODERADA)

EN LA SALA

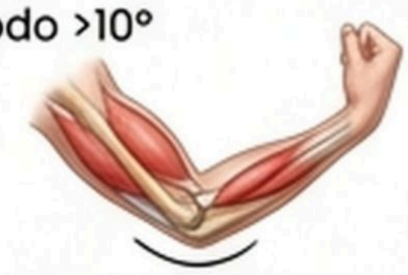
Para todos: “En esta postura, busquen la sensación de alargar y a la vez resistir, como si se expandieran desde un centro fuerte”.

PLANTILLA: FICHA DE HIPERMOVILIDAD

FICHA DE SEGUIMIENTO DE HIPERMOVILIDAD

Nombre del alumno/a: ..... **Fecha:** .....

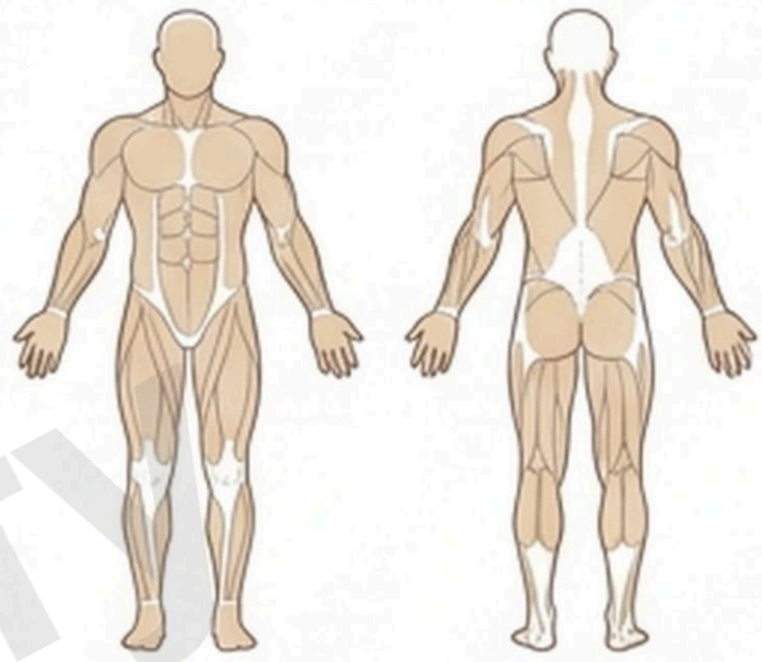
TABLA DEL TEST DE BEIGHTON (9 PUNTOS)

Articulación Evaluada	Puntaje Derecha	Puntaje Izquierda
Meñique >90° 	☐ (D)	☐ (I)
Pulgar a antebrazo 	☐ (D)	☐ (I)
Codo >10° 	☐ (D)	☐ (I)
Rodilla >10° 	☐ (D)	☐ (I)
Manos al piso 	☐	

Puntaje total: ___/9

MAPA CORPORAL

Marcar con "R" las zonas de rigidez percibida y con "D" las zonas de dolor o inestabilidad



SECCIÓN DE OBJETIVOS

- ☐ Mejorar estabilidad de hombros
- ☐ Mejorar estabilidad de caderas
- ☐ Control de hiperextensión (rodilla/codo)
- ☐ Fortalecimiento del core
- ☐ Reducir dolor en (especificar): _____

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

Fecha	Ejercicios clave realizados	Sensaciones reportadas por el/la alumno/a	Notas del profesor

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO

Usá esta ficha para llevar un registro objetivo de tu alumna hiperlaxa.
Te ayudará a visualizar sus patrones, a establecer objetivos claros y a medir el progreso más allá del rango de movimiento.
Reevaluá el mapa corporal y los objetivos cada 4-6 semanas.

PERFIL DEL ALUMNO HIPERLAXO: QUÉ SÍ, QUÉ NO Y CUÁNDO DERIVAR

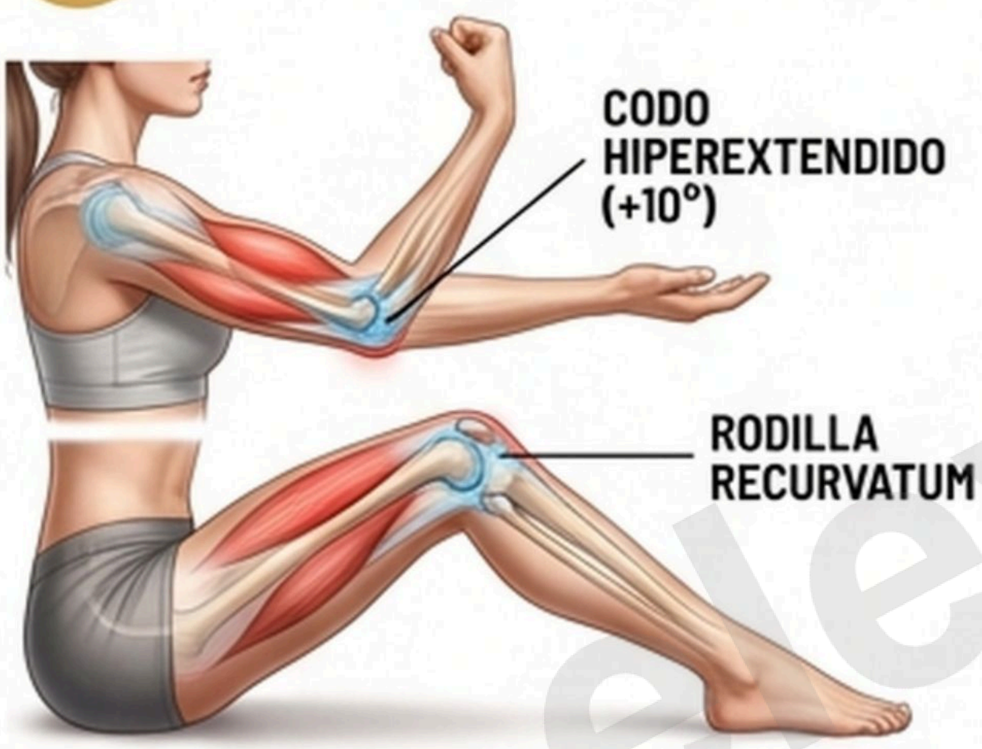
PERFIL DEL ALUMNO	QUÉ SÍ HACER (ENFOQUE)	QUÉ NO HACER (EVITAR)	CUÁNDO DERIVAR
 **HIPERLAXO ASINTOMÁTICO** Sin dolor, gran rango	✅ Foco en prevención: fuerza en rango final, control motor.	❌ Evitar forzar rangos extremos pasivos.	⚠️ Derivar si aparece dolor persistente.
 **HIPERLAXO CON DOLOR MUSCULAR (FALSA RIGIDEZ)** Tensión constante	✅ Foco en control excéntrico y movilidad activa (CARs).	❌ Evitar estiramiento pasivo sostenido.	⚠️ Derivar si el dolor no mejora o empeora.
 **HIPERLAXO CON INESTABILIDAD ARTICULAR (EJ: HOMBRO)** Sensación de “salirse”	✅ Foco en fortalecimiento de estabilizadores (manguito rotador, core).	❌ Evitar movimientos balísticos o sin control en rango final.	⚠️ Derivar siempre para diagnóstico preciso.
 **DOLOR AGUDO EN LA INGLE (SOSPECHA DE FAI)** Pinchazo profundo	✅ No hacer nada que provoque el pinzamiento.	❌ Evitar flexión de cadera profunda con rotación.	⚠️ Derivar inmediatamente al médico.
 **DOLOR IRRADIADO, HORMIGUEO, ADORMECIMIENTO** Síntomas nerviosos	✅ No hacer ningún ejercicio que provoque los síntomas.	❌ Evitar posiciones de compresión nerviosa.	⚠️ Derivar inmediatamente al médico.
 **POST LESIÓN CON ALTA KINESIOLÓGICA** Recuperación reciente	✅ Seguir pautas del kinesiólogo, carga progresiva.	❌ Evitar volver bruscamente a la actividad previa.	⚠️ Comunicarse con el profesional a cargo.

HIPERMOVILIDAD: CUANDO MÁS NO ES MEJOR

Guía esencial para el instructor de flexibilidad

La hipermovilidad articular, a menudo confundida con una ventaja, presenta desafíos únicos en la sala de clase. Para estos alumnos, el objetivo principal no es aumentar el rango de movimiento, sino construir estabilidad, control y conciencia corporal. Esta guía te ayudará a identificar las señales y adaptar tu enfoque para una práctica segura y sostenible.

EN LA SALA: SEÑALES COMUNES



Observa articulaciones que 'van más allá' del rango neutro, como codos y rodillas que se curvan hacia atrás, o pulgares que tocan el antebrazo fácilmente. A menudo acompañado de piel elástica o propensión a moretones.

RIESGOS PRINCIPALES (NO ES ELASTICIDAD)

- **Inestabilidad Articular:** Mayor riesgo de subluxaciones y esguinces recurrentes debido a la laxitud de los ligamentos.
- **Lesiones de Tejidos Blandos:** Tendinopatías, distensiones musculares y fatiga crónica por el sobreesfuerzo de los músculos estabilizadores.
- **Dolor Crónico y Artrosis Prematura:** El desgaste articular acelerado puede llevar a dolor persistente y degeneración articular temprana.

NOTA: La hipermovilidad puede estar asociada a condiciones como el Sindrome de Ehlers-Danlos (SED). Si sospechas esto, **SIEMPRE** deriva a un médico.

ESTRATEGIAS CLAVE PARA EL INSTRUCTOR

- **Priorizar Estabilidad y Fuerza:** Enfocar en ejercicios isométricos y de control motor. El objetivo es "aprender a parar" antes del limite articular, no a empujarlo. Incorporar trabajo de core y fortalecimiento alrededor de las articulaciones hiperlaxes.
- **Evitar Estiramientos Pasivos Extremes:** No forzar ni usar peso externo en posiciones de rango máximo. En su lugar, utilizar estiramientos activos y dinámicos controlados. Usar apoyos (bloques, pared) para limitar el rango y proporcionar retroalimentación.
- **Conciencia Corporal y Propiocepción:** Enseñar al alumno a sentir la activación muscular y la alineación articular, en lugar de depender únicamente de la sensación de estiramiento intenso. Usar señales verbales y táctiles suaves para corregir la postura.

CUE DE LA FORMADORA: "Busca la sensación de trabajo muscular, no solo la de estiramiento profundo. Controla el movimiento en todo momento."